Dataset Penyakit Kucing
— Versi Ringkas

Versi padat dari Dataset Penyakit Kucing lengkap (50 penyakit). Setiap entri dipadatkan dari laporan riset masing-masing penyakit: apa itu, tanda khas, tanda darurat, penanganan inti, pencegahan inti, peringatan penting bila ada, dan sumber utama. Halaman ini bersifat edukasi dan bukan pengganti diagnosis dokter hewan. Untuk detail lengkap 14 komponen per penyakit, lihat halaman Dataset Penyakit Kucing.

Halaman ini adalah versi ringkas dari Dataset Penyakit Kucing lengkap (50 penyakit, 14 komponen per penyakit). Setiap entri di bawah dipadatkan dari laporan riset masing-masing penyakit, dengan format: Apa itu, Ciri-ciri umum, Tanda khas, Tanda darurat, Penanganan inti, Pencegahan inti, Peringatan penting (hanya bila ada peringatan kritis), dan Sumber utama (maksimal 3).

Entri 01 — Panleukopenia Kucing (Feline Panleukopenia)

Apa itu: Infeksi parvovirus kucing yang sangat menular dan sering fatal, menyerang sel-sel yang membelah cepat (sumsum tulang, jaringan limfoid, dan lapisan usus) sehingga jumlah sel darah putih anjlok drastis.

Ciri-ciri umum: Demam tinggi, lesu, dan tidak mau makan muncul dulu, disusul muntah berulang dan diare yang dapat berdarah, disertai dehidrasi yang berkembang cepat dan nyeri perut. Bulu kusam dan leleran mata/hidung bernanah akibat infeksi sekunder juga dilaporkan, serta abortus pada induk bunting.

Tanda khas: Tidak ada satu gejala patognomonik; yang menonjol adalah kombinasi kucing muda yang belum divaksinasi lengkap dengan demam, muntah, diare (dapat berdarah), dan panleukopenia berat pada pemeriksaan darah, serta kematian mendadak pada anak kucing.

Tanda darurat: Depresi yang memburuk hingga kolaps, kematian mendadak (terutama anak kucing), hipotermia, syok sepsis, dehidrasi berat yang sangat cepat, serta diare berdarah hebat disertai muntah terus-menerus.

Penanganan inti: Tidak ada antivirus spesifik; perawatan berupa isolasi dan perawatan penghalang, cairan infus dan elektrolit secara agresif, antibiotik spektrum luas untuk infeksi bakteri sekunder (bukan untuk virusnya), antimuntah, dukungan nutrisi, dan transfusi bila anemia atau kehilangan protein berat.

Pencegahan inti: Vaksin inti FVRCP, desinfeksi dengan pemutih, isolasi kucing yang sembuh hingga 6 minggu karena masih dapat menularkan virus, dan memelihara kucing di dalam rumah.

Peringatan penting: Vaksin hidup yang dilemahkan (MLV) tidak boleh dipakai pada kucing betina bunting atau anak kucing berusia di bawah 4 minggu; tidak ada pengobatan rumahan yang terbukti menggantikan perawatan dokter hewan.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/feline-panleukopenia-virus); VCA Canada (https://vcacanada.com/know-your-pet/feline-panleukopenia); European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-feline-panleukopenia/)

Entri 02 — Herpesvirus Kucing / Rhinotracheitis Virus Kucing (Feline Herpesvirus Infection, FHV-1)

Apa itu: Infeksi virus pada saluran napas atas dan mata kucing yang menetap seumur hidup dalam keadaan laten dan dapat kambuh, terutama setelah stres.

Ciri-ciri umum: Bersin berulang, hidung tersumbat, dan leleran hidung-mata yang awalnya jernih lalu menjadi mukopurulen, disertai demam, lesu, dan nafsu makan menurun. Gejala mata berupa konjungtivitis, mata merah dan berair, serta sering menyipit, ditambah salivasi berlebihan dan sakit tenggorokan juga umum.

Tanda khas: Ulkus kornea dendritik (bercabang) yang menurut ABCD dianggap patognomonik, dengan dominasi gejala mata dan hidung (berbeda dengan FCV yang dominan di mulut), serta konjungtivitis atau keratitis yang kambuh berulang.

Tanda darurat: Tidak ada daftar darurat resmi; dari kasus berat, perlu segera diperiksa bila ada sesak atau napas berat, dehidrasi, depresi berat, tidak mau makan, mata nyeri atau terus tertutup, mata keruh, atau dugaan ulkus kornea, serta anak kucing baru lahir yang memburuk cepat.

Penanganan inti: Tidak ada obat penyembuh; perawatan suportif berupa nutrisi dan hidrasi, membersihkan leleran dengan cairan garam, nebulisasi atau uap, pelumas mata, antibiotik hanya untuk infeksi bakteri sekunder, dan antivirus (trifluridin topikal atau famsiklovir sistemik) terutama untuk penyakit mata.

Pencegahan inti: Vaksin inti FVRCP mengurangi keparahan dan penularan tetapi tidak sepenuhnya mencegah infeksi atau latensi, ditambah kebersihan dan desinfeksi, isolasi kucing sakit, manajemen stres, dan karantina kucing baru 1–2 minggu di rumah (3 minggu di penampungan).

Peringatan penting: L-lisin tidak direkomendasikan (Cornell dan ABCD); jangan memakai obat flu atau dekongestan manusia tanpa perintah dokter hewan, dan kortikosteroid mata umumnya dihindari.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/respiratory-infections); VCA Canada (https://vcacanada.com/know-your-pet/feline-herpesvirus-infection-or-feline-viral-rhinotracheitis); European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-feline-herpesvirus-infection/)

Entri 03 — Calicivirus Kucing (Feline Calicivirus Infection, FCV)

Apa itu: Virus yang sangat menular yang menyebabkan infeksi pernapasan dan penyakit mulut ringan hingga berat; sebagian besar kucing pulih penuh, tetapi galur virulen yang jarang dapat mematikan.

Ciri-ciri umum: Bersin, hidung tersumbat, pilek dan leleran mata, konjungtivitis, serta demam, lesu, nafsu makan menurun, dan pembesaran kelenjar getah bening. Ulkus pada lidah dan mulut disertai liur berlebihan karena nyeri juga umum, dan pada anak kucing dapat terjadi pneumonia.

Tanda khas: Ulkus mulut dan lidah disertai liur berlebihan; sindrom pincang berpindah yang bersifat sementara, terutama pada anak kucing; pada bentuk virulen (VS-FCV) muncul bengkak kepala dan tungkai, lesi kulit berkeropeng, kuning, dan perdarahan.

Tanda darurat: Demam tinggi menetap, depresi berat, bengkak kepala, wajah, atau tungkai, ulkus kulit berkeropeng dan kerontokan bulu, kuning, perdarahan (bintik merah di kulit, mimisan, tinja berdarah), sesak berat atau kegagalan multiorgan, serta tidak makan lebih dari 3 hari dan dehidrasi; mortalitas VS-FCV dilaporkan berkisar 30–79% antar sumber.

Penanganan inti: Tidak ada antivirus spesifik; perawatan suportif berupa membersihkan hidung dan mata, uap atau nebulisasi, makanan lunak hangat yang menggugah selera, pereda nyeri dan demam atas arahan dokter hewan (NSAID hanya setelah dehidrasi teratasi), antibiotik hanya untuk infeksi bakteri sekunder, serta cairan infus dan rawat inap pada kasus berat; ribavirin beracun bagi kucing dan tidak dipakai.

Pencegahan inti: Vaksin inti FVRCP mengurangi keparahan tetapi tidak sepenuhnya mencegah infeksi, ditambah kebersihan dan desinfeksi (natrium hipoklorit

dan sejenisnya), isolasi kucing sakit, dan isolasi kucing baru 1–2 minggu (3 minggu untuk rumah tangga bebas FCV).

Peringatan penting: Pembersih berbahan fenol (misalnya Lysol) beracun bagi kucing — jangan dipakai di sekitar kucing; NSAID hanya atas arahan dokter hewan.

Sumber utama: Cornell Baker Institute (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/baker-institute-animal-health/research-baker-institute/feline-calicivirus); European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-feline-calicivirus-infection/); International Cat Care (https://icatcare.org/articles/feline-calicivirus-fcv)

Entri 04 — Leukemia Kucing (Feline Leukemia Virus Infection, FeLV)

Apa itu: Retrovirus yang menekan sistem imun kucing dan dapat menyebabkan anemia, limfoma atau leukemia, serta infeksi sekunder berulang; tidak ada obat penyembuh.

Ciri-ciri umum: Pada awal infeksi kucing sering tanpa gejala, lalu kesehatan memburuk perlahan dengan nafsu makan hilang, penurunan berat badan progresif, bulu buruk, demam persisten, dan pembesaran kelenjar getah bening. Gusi pucat, radang gusi dan mulut, infeksi kulit, kandung kemih, dan saluran napas atas yang berulang, serta diare persisten juga sering terjadi.

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; polanya adalah sakit berulang atau progresif, anemia mencolok (gusi pucat, lemas makin berat), limfoma, penyakit mulut berat disertai infeksi berulang, dan gangguan reproduksi, dengan konfirmasi definitif lewat tes antigen, bukan gejala.

Tanda darurat: Tidak ada daftar darurat resmi; tanda bahaya dari manifestasi berat meliputi gusi sangat pucat disertai lemas berat, sesak napas, kejang atau perubahan perilaku mendadak, perdarahan tak berhenti atau memar tanpa sebab jelas, penolakan total makan dan minum, muntah atau diare berat yang tidak membaik, dan perburukan cepat.

Penanganan inti: Tidak ada obat penyembuh; infeksi sekunder diobati segera, perawatan suportif berupa nutrisi baik, kontrol dokter hewan setidaknya tiap 6 bulan, pengendalian parasit, dan minimalisasi stres, transfusi untuk anemia berat, kemoterapi untuk limfoma terkait FeLV, serta antivirus atau imunomodulator hanya dengan bukti awal dan terbatas, bukan standar.

Pencegahan inti: Cegah paparan sebagai satu-satunya cara pasti — pelihara di dalam rumah, pisahkan kucing positif dari kucing negatif, tes semua kucing

sebelum adopsi atau vaksinasi — ditambah vaksinasi non-inti berbasis risiko yang mengurangi risiko tetapi tidak 100%, dan kebersihan karena virus ini rapuh terhadap disinfektan, sabun, dan panas.

Peringatan penting: Vaksinasi tidak membantu setelah infeksi terjadi; jangan memberi antivirus, antibiotik, atau steroid manusia tanpa resep dokter hewan; kucing positif sebaiknya disteril dan dipelihara ketat di dalam rumah.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/feline-leukemia-virus-brochure); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/feline-leukemia-virus-disease-complex); International Cat Care (https://icatcare.org/articles/feline-leukaemia-virus-felv)

Entri 05 — Virus Imunodefisiensi Kucing (Feline Immunodeficiency Virus Infection, FIV)

Apa itu: Infeksi virus kronis seumur hidup yang menyerang sistem imun kucing (sel T CD4+), membuat kucing rentan terhadap infeksi sekunder, dengan perjalanan lambat dari fase akut ke fase tanpa gejala (berbulan-bulan hingga bertahun-tahun) lalu imunodefisiensi progresif.

Ciri-ciri umum: Tidak ada gejala yang spesifik untuk FIV; fase akut berupa demam sementara, pembesaran kelenjar getah bening, lesu, dan nafsu makan menurun, yang sering ringan dan terlewat. Setelah masa tanpa gejala yang panjang, muncul penurunan berat badan, demam berulang, bulu kusam, radang gusi dan mulut kronis, serta infeksi kulit, mata, pernapasan, kemih, dan cerna yang kronis atau berulang.

Tanda khas: Tidak ada tanda patognomonik; polanya adalah infeksi kronis-berulang yang tidak sembuh, radang gusi dan mulut kronis yang menonjol, profil risiko yang cocok (jantan tidak dikebiri, akses luar rumah, riwayat berkelahi), dan periode tanpa gejala yang sangat panjang diikuti penurunan bertahap, dengan konfirmasi lewat tes darah.

Tanda darurat: Tidak ada daftar resmi; perlu segera diperiksa bila ada penurunan berat badan cepat atau menetap, demam menetap, penolakan makan, letargi berat, kejang atau perubahan neurologis dan perilaku mendadak, luka tak sembuh, diare atau muntah berkepanjangan, serta kesulitan bernapas atau makan akibat radang mulut berat; kucing sehat dengan tes positif bukan keadaan darurat dan tidak pernah menjadi alasan eutanasia.

Penanganan inti: Tidak ada obat penyembuh definitif; infeksi sekunder diobati (antibiotik sering lebih lama dan intensif), perawatan gigi, diagnostik dini yang intensif, antivirus terbatas (AZT dapat membantu stomatitis berat atau penyakit neurologis tetapi tidak terbukti memperpanjang hidup dan dapat berefek samping serius), serta perawatan suportif berupa kontrol dokter hewan setidaknya tiap 6 bulan, makanan komersial berkualitas, hindari makanan mentah, pengendalian parasit rutin, hidup di dalam rumah, sterilisasi, dan pengurangan stres.

Pencegahan inti: Cegah paparan gigitan sebagai satu-satunya cara pasti — pelihara di dalam rumah, sterilisasi, tes semua kucing sebelum diperkenalkan, dan pisahkan kucing positif dari kucing negatif bila ada risiko berkelahi — ditambah kebersihan dan desinfeksi; vaksin FIV tidak tersedia di Amerika Utara sejak 2016 dan tidak tersedia di Eropa, tersedia di Australia, Selandia Baru, dan Jepang, dan ketersediaannya di Indonesia belum terverifikasi.

Peringatan penting: Jangan pernah melakukan eutanasia hanya karena tes positif pada kucing yang sehat; hindari griseofulvin karena menyebabkan penekanan sumsum tulang pada kucing FIV.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/feline-immunodeficiency-virus-fiv); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/feline-immunodeficiency-virus-infection); European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-feline-immunodeficiency-virus/)

Entri 06 — Peritonitis Infeksiosa Kucing (Feline Infectious Peritonitis, FIP)

Apa itu: Penyakit virus multisistem yang dimediasi imun, ketika coronavirus kucing yang bermutasi memicu peradangan berat di sekitar pembuluh darah; sebagian besar infeksi coronavirus kucing tidak pernah menjadi FIP (sekitar 5–12%).

Ciri-ciri umum: Gejala awal tidak spesifik: lesu, nafsu makan menurun sampai hilang, penurunan atau gagal menambah berat badan, dan demam berfluktuasi yang tidak merespons antibiotik. Infeksi coronavirus awal sendiri sering tanpa gejala, atau hanya bersin, mata berair, sekret hidung, dan muntah/diare ringan yang sembuh sendiri.

Tanda khas: Tidak ada tanda patognomonik; bentuk basah ditandai perut membuncit karena cairan (asites), cairan pleura yang menyebabkan sesak, dan cairan kental kuning jerami berprotein tinggi, sedangkan bentuk kering ditandai uveitis mata

(sekitar 30% kasus), gejala neurologis (sekitar 30%), serta massa atau pembesaran organ perut, didukung pola laboratorium berupa limfopenia, anemia non-regeneratif, globulin tinggi, dan rasio A:G rendah.

Tanda darurat: Tidak ada daftar triase resmi; dari manifestasi yang terdokumentasi, perlu segera diperiksa bila ada sesak atau napas cepat akibat cairan pleura, kejang, kolaps, tidak dapat berjalan, kebutaan mendadak, perut membesar cepat disertai sesak, kuning berat, lemas ekstrem, penolakan total makan dan minum, atau perburukan cepat.

Penanganan inti: Kini dapat diobati dan sering disembuhkan dengan antivirus — GS-441524 sebagai lini pertama, remdesivir intravena untuk kucing yang sangat sakit, dan molnupiravir sebagai penyelamat setelah kambuh atau gagal — ditambah perawatan suportif berupa cairan infus, nutrisi, transfusi, drainase cairan dada bila sesak, obat tetes mata, dan obat antikejang; steroid saja bukan terapi definitif; durasi terapi masih diperdebatkan, minimum 84 hari menurut MSD berbanding 42 hari yang terbukti efektif menurut ABCD 2026, terutama untuk kasus efusif.

Pencegahan inti: Tidak ada pencegahan absolut selain mencegah infeksi coronavirus kucing (sulit karena virus tersebar luas); hanya ada satu vaksin intranasal berlisensi yang efektivitasnya dipertanyakan dan tidak direkomendasikan rutin, ditambah kepadatan rendah (maksimal 3 kucing per ruangan), kotak pasir memadai dengan pembersihan dan desinfeksi harian, dan minimalisasi stres.

Peringatan penting: Jangan menghentikan terapi lebih awal hanya karena perbaikan cepat; status legal dan akses antivirus FIP di Indonesia belum terverifikasi — jangan membeli dari sumber daring tak teregulasi; jangan memakai antivirus rutin untuk mencegah penularan pada kucing non-FIP karena risiko resistensi.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/feline-infectious-peritonitis); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/feline-infectious-peritonitis); European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) 2026 (https://www.mdpi.com/1999-4915/18/4/452)

Entri 07 — Rabies pada Kucing (Rabies)

Apa itu: Penyakit virus akut yang menyerang sistem saraf pusat semua mamalia; dapat dicegah dengan vaksinasi tetapi tidak dapat disembuhkan begitu gejala muncul, dan

hampir selalu fatal.

Ciri-ciri umum: Gejala awal tidak spesifik: perubahan temperamen mendadak, gelisah, vokalisasi meningkat, bersembunyi, serta demam, tidak mau makan, muntah, dan diare. Selanjutnya muncul fase ganas (agresif dan menyerang tanpa provokasi, hipersensitif terhadap cahaya, suara, dan sentuhan) atau fase paralitik (kelemahan progresif, sempoyongan, sulit menelan, liur berlebihan, kejang, hingga koma).

Tanda khas: Tidak ada tanda patognomonik; kombinasi perubahan perilaku mendadak yang dramatis dan agresi tanpa provokasi, pupil sangat melebar yang tidak bereaksi terhadap cahaya, liur berlebihan disertai ketidakmampuan menelan, bentuk ganas pada sekitar 90% kasus kucing, dan kelumpuhan menaik; hidrofobia bukan gejala pada kucing (itu ciri pada manusia).

Tanda darurat: Tidak ada bentuk ringan; semua kasus bergejala adalah serius — segera cari pertolongan bila ada perubahan perilaku mendadak, agresi tanpa provokasi, liur atau ketidakmampuan menelan, pupil melebar, sempoyongan, lemas atau kelumpuhan, kejang, atau koma, serta setiap gigitan atau cakaran hewan liar, hewan bebas berkeliaran, atau hewan dengan status vaksinasi tak diketahui; manusia yang digigit harus mencuci luka minimal 15 menit dan segera mencari perawatan medis untuk profilaksis pascapajanan; kematian biasanya dalam 1–10 hari (umumnya 3–4 hari menurut ABCD).

Penanganan inti: Tidak ada pengobatan atau obat penyembuh untuk kucing bergejala; penanganannya berupa isolasi, pelaporan ke otoritas, dan eutanasia yang manusiawi yang direkomendasikan, sedangkan kucing terpapar tetapi belum bergejala yang sudah divaksinasi mendapat booster dan observasi 45 hari, dan yang belum divaksinasi menghadapi eutanasia atau karantina ketat 4 bulan (panduan NASPHV AS; ikuti otoritas setempat); manusia yang tergigit harus mencuci luka minimal 15 menit dan segera mencari perawatan untuk profilaksis pascapajanan.

Pencegahan inti: Vaksinasi semua kucing (dosis pertama usia 12–16 minggu menurut ABCD dengan booster setahun kemudian; VCA menyebut 3–4 bulan), pelihara kucing di dalam rumah, dan hindari kontak dengan satwa liar atau kucing liar; di Indonesia, 26 dari 38 provinsi endemis menurut Kemenkes 2025, tetapi jumlah kasus khusus kucing belum terverifikasi.

Peringatan penting: Hampir selalu fatal setelah gejala muncul — jangan menunggu perburukan; hidrofobia bukan gejala kucing; jangan menangani satwa liar dengan tangan kosong; korban gigitan manusia harus segera mencari perawatan, jangan menunda profilaksis pascapajanan.

Sumber utama: European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-feline-rabies/); Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/rabies-infections-and-prevention); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/rabies-in-cats)

Entri 08 — Penyakit Saluran Kemih Bawah pada Kucing (Feline Lower Urinary Tract Disease, FLUTD)

Apa itu: Istilah payung untuk gangguan kandung kemih dan uretra, bukan satu penyakit tunggal, dengan penyebab tersering sistitis idiopatik kucing (FIC), diikuti batu, infeksi, dan penyebab lainnya.

Ciri-ciri umum: Mengejan saat berkemih dengan urine hanya sedikit, berkemih lebih sering, darah dalam urine, dan berkemih di luar kotak pasir. Kucing juga sering menangis saat berkemih, bolak-balik ke kotak pasir, menjilat area genital berlebihan, dan berubah perilaku menjadi pendiam atau mudah marah.

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; pembeda utama adalah obstruktif versus non-obstruktif — kucing non-obstruktif masih mengeluarkan sedikit urine berulang kali, sedangkan kucing obstruktif mengejan berulang dengan sedikit atau tanpa urine disertai kegelisahan meningkat dan kandung kemih membesar yang nyeri; pola usia membantu (di bawah 10 tahun umumnya FIC, di atas 10 tahun infeksi saluran kemih jauh lebih mungkin), jantan (terutama yang dikebiri) berisiko obstruksi jauh lebih tinggi, mengejan sering disangka konstipasi sehingga pemeriksaan aman di rumah adalah apakah ada urine yang keluar, dan buang air dalam volume besar bukan ciri inti FLUTD melainkan mengarah ke penyakit sistemik.

Tanda darurat: Obstruksi uretra adalah darurat mutlak — mengejan berulang tanpa urine sama sekali atau hanya tetesan, kegelisahan meningkat, menangis kesakitan terus-menerus, perut tegang dan nyeri, muntah, dehidrasi, hipotermia, depresi berat atau kolaps (uremia), serta detak jantung lambat atau aritmia akibat kalium tinggi; kematian sering terjadi dalam kurang dari 24–48 jam pada obstruksi total.

Penanganan inti: Tergantung penyebab yang ditemukan — tidak ada satu obat FLUTD untuk semua; penanganan umum berupa peningkatan asupan air (makanan basah), pereda nyeri atas resep dokter hewan, manajemen stres dan lingkungan (MEMO), dan kontrol berat badan; batu struvit dilarutkan dengan diet resep dokter hewan, batu kalsium oksalat tidak dapat dilarutkan sehingga dikeluarkan lewat pembilasan atau operasi, infeksi

saluran kemih diobati dengan antibiotik berdasarkan kultur dan uji sensitivitas, dan obstruksi ditangani darurat di klinik lewat stabilisasi dan kateterisasi dengan sedasi atau anestesi, cairan infus, dan rawat inap, dengan operasi perineal urethrostomy hanya sebagai pilihan terakhir untuk obstruksi berulang.

Pencegahan inti: Utamakan makanan basah daripada makanan kering saja, sediakan air bersih segar selalu, diet khusus saluran kemih hanya atas rekomendasi dokter hewan, jaga berat badan ideal dan dorong bermain, kelola stres dan lingkungan (MEMO), sediakan kotak pasir sejumlah kucing ditambah satu di lokasi berbeda dengan pembuangan kotoran idealnya dua kali sehari, dan pantau kebiasaan berkemih setiap hari; tidak ada vaksin pencegahan FLUTD.

Peringatan penting: Jangan mencoba mengosongkan kandung kemih yang tersumbat di rumah dengan menekan perut (risiko pecah); jangan memberi obat manusia, obat kucing lain, atau antibiotik tanpa resep dokter hewan; jangan salah mengira mengejan sebagai konstipasi.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/feline-lower-urinary-tract-disease); International Cat Care (https://icatcare.org/articles/feline-lower-urinary-tract-disease); Merck Veterinary Manual (https://www.merckvetmanual.com/urinary-system/noninfectious-diseases-of-the-urinary-system-in-small-animals/lower-urinary-tract-disease-in-cats)

Entri 09 — Penyakit Ginjal Kronis pada Kucing (Chronic Kidney Disease, CKD)

Apa itu: Kehilangan fungsi ginjal yang menetap dan progresif selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, ketika jaringan ginjal fungsional diganti jaringan parut sehingga ginjal tidak lagi menyaring limbah darah dengan baik.

Ciri-ciri umum: Gejala timbul perlahan dan sering tidak ada sama sekali pada stadium awal; yang paling sering dilaporkan adalah minum dan kencing lebih banyak, penurunan berat badan bertahap, nafsu makan menurun, muntah, serta letargi dan bulu kusam. Pada stadium lanjut dapat muncul dehidrasi, gusi pucat akibat anemia, napas berbau uremik, sariawan mulut, dan konstipasi.

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; pembedanya adalah kombinasi dan perjalanan berupa banyak minum dan banyak kencing yang berlangsung perlahan dan menetap (bulan hingga tahun) disertai penurunan berat badan dan massa otot

bertahap, urine encer yang persisten (berat jenis urine di bawah 1,035 sebagai tanda paling awal menurut VCA), azotemia persisten pada pengukuran berulang, dan ginjal kecil, keras, dengan tepi tak teratur pada USG — berbeda dengan gagal ginjal akut yang mendadak.

Tanda darurat: Tidak ada daftar krisis uremia kanonik tunggal; dari sintesis beberapa sumber, perlu segera diperiksa bila ada muntah berulang, penolakan makan total, letargi sangat berat hingga kolaps, dehidrasi berat, sariawan mulut yang nyeri, napas berbau amonia atau uremik yang kuat, dan penurunan kondisi cepat, serta kebutaan mendadak, disorientasi, kelemahan mendadak, atau kejang, dan tidak kencing sama sekali atau sangat sedikit dengan perut nyeri atau membesar dan mengejan tanpa urine keluar (lebih mengarah ke gagal ginjal akut atau obstruksi).

Penanganan inti: Tidak ada obat penyembuh; tujuannya memperlambat progresi dan menjaga kualitas hidup lewat diet terapeutik ginjal (terbukti memperpanjang hidup, transisi bertahap minimal 1–2 minggu, dan kucing tidak boleh dibiarkan tidak makan), hidrasi yang baik termasuk makanan basah dan banyak sumber air serta cairan subkutan di rumah pada sebagian kucing stadium lanjut, cairan infus di klinik pada krisis, serta obat atas resep dokter hewan untuk hipertensi, proteinuria, anemia, fosfor tinggi, mual, kalium rendah, dan infeksi yang terbukti, dengan pemantauan rutin berat badan, tekanan darah, dan tes darah serta urine.

Pencegahan inti: Sebagian besar kasus tidak dapat dicegah sepenuhnya karena usia dan genetik; yang terverifikasi adalah skrining berkala pada kucing berusia 7 tahun ke atas (tahunan pada usia 7–10 tahun, dua kali setahun di atas 10 tahun), dorong asupan air sejak dini, hindari nefrotoksin (semua bagian tanaman lili, antibeku, dan obat manusia atau hewan tanpa pengawasan dokter hewan), segera koreksi dehidrasi saat sakit lain, dan kelola komorbiditas sejak dini (hipertensi, proteinuria, infeksi saluran kemih, dan obstruksi); diet pencegahan khusus untuk kucing sehat dan kontrol berat badan sebagai pencegah CKD belum terverifikasi, dan vaksinasi tidak terverifikasi sebagai pencegah CKD.

Peringatan penting: Jangan menghentikan makan demi diet baru; jangan memberi obat ginjal manusia, pengikat fosfat bebas, atau terapi cairan dari instruksi internet tanpa arahan dokter hewan.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/node/4058); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/kidney-failure-chronic-in-cats); International Cat Care 2026

(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13554608/)

Entri 10 — Hipertiroidisme pada Kucing (Feline Hyperthyroidism, Thyrotoxicosis)

Apa itu: Gangguan endokrin tersering pada kucing paruh baya dan tua akibat produksi hormon tiroid (T3 dan T4) yang berlebihan dari kelenjar tiroid di leher, sehingga tubuh bekerja terlalu cepat dan membakar energi berlebihan.

Ciri-ciri umum: Gejala awal halus lalu memburuk: penurunan berat badan meski nafsu makan meningkat, haus dan buang air kecil meningkat, hiperaktivitas dan gelisah, serta vokalisasi meningkat. Muntah dan/atau diare, bulu kusam, denyut dan napas cepat, serta intoleransi panas juga umum, sedangkan sebagian kecil kucing justru menunjukkan bentuk apatis (nafsu makan menurun, lesu, dan depresi).

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; pembedanya adalah kombinasi penurunan berat badan dengan nafsu makan tetap atau meningkat (berbeda dari sebagian besar penyebab penurunan berat badan lain yang disertai nafsu makan menurun), gondok yang teraba di leher (ketiadaannya tidak menyingkirkan diagnosis), takikardia disertai hiperaktivitas, kegelisahan, dan vokalisasi meningkat pada kucing tua, serta intoleransi panas dan terengah-engah saat stres, dengan konfirmasi laboratorium berupa T4 darah yang meningkat.

Tanda darurat: Sesak napas, bernapas dengan mulut terbuka, atau napas sangat cepat atau sulit (kemungkinan gagal jantung, efusi pleura, atau edema paru), kebutaan mendadak atau pupil melebar tak bereaksi terhadap cahaya (kemungkinan krisis hipertensi dengan lepasnya retina), kolaps, kelemahan berat, tidak dapat berdiri atau menggerakkan kaki belakang, atau kelumpuhan mendadak (tromboemboli), kejang, disorientasi berat, atau kehilangan kesadaran, serta muntah atau diare tak terkendali, berhenti makan, atau menguning; bentuk akut yang jarang, krisis tiroid (thyroid storm), dapat dipicu terapi radioiodin, pembedahan tiroid, palpasi tiroid yang kuat, penghentian mendadak obat antitiroid, stres, penyakit, atau infeksi.

Penanganan inti: AAFP merekomendasikan pengobatan untuk semua kucing hipertiroid dengan tujuan mengembalikan kadar hormon normal; empat pilihan utama adalah obat antitiroid (metimazol atau karbimazol, mengendalikan bukan menyembuhkan, biasanya seumur hidup), diet yodium terbatas yang harus dimakan secara eksklusif seumur hidup, terapi radioiodin I-131 sebagai pengobatan pilihan bila tersedia (tingkat kesembuhan sekitar 95–98% dengan satu pengobatan menurut Cornell Hospital, dengan rawat inap 3–5 hari), dan pembedahan tiroid (tiroidektomi, kini jarang dipilih), ditambah penanganan penyakit penyerta dan pemantauan berkala fungsi ginjal,

tekanan darah, dan kadar hormon tiroid.

Pencegahan inti: Tidak ada pencegahan yang terbukti karena penyebab dasarnya belum diketahui; yang terverifikasi adalah deteksi dini lewat panel kesehatan geriatri yang rutin memasukkan T4 serum dan pemeriksaan kesehatan rutin pada kucing tua untuk mendeteksi penurunan berat badan yang tak dapat dijelaskan dan memeriksa kadar tiroid; tidak ada bukti diet tertentu atau pengurangan paparan bahan kimia rumah tangga mencegah penyakit ini, dan vaksinasi bukan pencegah hipertiroidisme.

Peringatan penting: Diet yodium terbatas adalah diet terapeutik resep dokter hewan, bukan perubahan makanan biasa, dan tidak boleh diberikan sembarangan tanpa diagnosis; tanpa pengobatan, penyakit ini mengancam jiwa dan memerlukan perhatian dokter hewan segera.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine, Cornell Feline Health Center (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/hyperthyroidism-cats); International Cat Care (https://icatcare.org/articles/hyperthyroidism-in-cats); American Association of Feline Practitioners (AAFP) 2016 (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11132203/)

Entri 11 — Diabetes melitus (Feline diabetes mellitus)

Apa itu: Diabetes melitus pada kucing paling sering menyerupai diabetes tipe 2 manusia: gangguan sel beta pankreas dan resistensi insulin sehingga glukosa darah menetap tinggi dan tumpah ke urine.

Ciri-ciri umum: Kencing dan minum lebih banyak, nafsu makan bertambah tetapi berat badan tetap atau turun, disertai lesu, bulu kusam, dan grooming menurun. Laporan mencatat hingga 50% kucing diabetik justru mengalami penurunan nafsu makan, sehingga nafsu makan yang meningkat bukan aturan mutlak.

Tanda khas: Tidak ada satu gejala patognomonik; kombinasi banyak minum, banyak kencing, nafsu makan tetap atau bertambah tetapi berat badan turun, ditambah sikap plantigrade (tumit menyentuh tanah) pada kasus lanjut tak terkontrol, dan pembuktian laboratorium berupa hiperglikemia persisten, glukosuria, dan fruktosamin meningkat.

Tanda darurat: Ketoasidosis diabetik (tidak mau makan, letargi, muntah, diare, dehidrasi, napas cepat atau sulit, bau napas manis atau buah, kolaps hingga koma) dan hipoglikemia akibat pengobatan (kelemahan, kurang koordinasi, kejang, koma).

Penanganan inti: Insulin suntik sebagai tulang punggung pengobatan, diet tinggi protein dan rendah karbohidrat, serta pemantauan glukosa rutin; ketoasidosis ditangani dengan rawat inap.

Pencegahan inti: Tidak ada strategi pencegahan yang diketahui; hanya pengurangan risiko melalui berat badan ideal, aktivitas bermain harian, porsi terkontrol, dan menghindari obat diabetogenik bila memungkinkan atas keputusan dokter hewan.

Peringatan penting: Pemilik tidak boleh mengubah dosis insulin tanpa berdiskusi dengan dokter hewan, dan jangan memaksa makanan atau cairan ke mulut kucing yang kejang atau koma.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/feline-diabetes); Merck Veterinary Manual (https://www.merckvetmanual.com/endocrine-system/the-pancreas/diabetes-mellitus-in-dogs-and-cats?query=feline%20diabetes); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/animal-medical-center-southern-california/services/canine-and-feline-diabetes/cat-diabetes)

Entri 12 — Asma (Feline asthma)

Apa itu: Penyakit kronis saluran napas bawah (bronki dan bronkiolus) akibat reaksi alergi terhadap alergen yang terhirup, yang menyebabkan peradangan, penyempitan saluran napas, dan sesak napas; mengenai 1–5% kucing.

Ciri-ciri umum: Batuk kering dalam serangan singkat, mengi, napas cepat atau sulit dengan usaha napas yang meningkat, dan napas lewat mulut terbuka yang tidak normal pada kucing. Di antara episode, kucing dapat tampak sepenuhnya normal, dan batuk kadang berakhir dengan retch yang menyerupai upaya mengeluarkan hairball.

Tanda khas: Tidak ada satu gejala patognomonik; postur serangan khas (tubuh membungkuk dekat tanah dengan leher dijulurkan ke depan), batuk kering yang berakhir dengan retch tanpa hairball sehingga sering disangka hairball, dan kesulitan terutama saat menghembuskan napas.

Tanda darurat: Napas mulut terbuka yang menetap, kesulitan bernapas yang jelas, kelemahan atau kolaps, bibir, hidung, atau gusi membiru atau pucat, serangan yang tidak membaik dengan obat penyelamat, atau laju napas saat tidur di atas 30 kali per menit.

Penanganan inti: Kortikosteroid sebagai anti-inflamasi utama (inhalasi lewat spacer khusus kucing lebih disukai untuk jangka panjang) ditambah bronkodilator sebagai penyelamat, bukan terapi tunggal; serangan akut ditangani di klinik dengan oksigen dan penanganan minimal.

Pencegahan inti: Singkirkan pemicu lewat coba-coba: rumah bebas asap rokok, litter rendah debu dan tanpa pewangi, hindari produk berpewangi dan aerosol, serta jaga berat badan ideal; bukti spesifik pada kucing masih terbatas sehingga ini bukan jaminan pencegahan.

Peringatan penting: Jangan menghentikan pengobatan karena kondisi ini seumur hidup; pengurangan dosis hanya setelah diskusi dengan dokter hewan.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/feline-asthma-risky-business-many-cats); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/bronchitis-in-cats); International Cat Care (https://icatcare.org/articles/asthma-and-chronic-bronchitis-in-cats)

Entri 13 — Ringworm (Dermatofitosis)

Apa itu: Infeksi jamur superfisial kulit, rambut, dan kadang kuku yang bukan disebabkan cacing; penyebab tersering pada kucing di seluruh dunia adalah Microsporum canis (lebih dari 90% kasus).

Ciri-ciri umum: Bercak botak melingkar dengan rambut patah dan kusam, disertai sisik, krusta, kemerahan, atau bintil kecil, terutama di wajah, telinga, kaki, dan ekor, dengan gatal yang bervariasi dari tidak ada sampai sedang. Sebagian kucing terinfeksi tidak menunjukkan gejala sama sekali.

Tanda khas: Tidak ada gejala visual yang memastikan ringworm; pola paling khas bila ada adalah alopesia melingkar teratur dengan rambut patah di tepi lesi dan deskuamasi, kadang dengan tepi kemerahan, serta fluoresensi hijau apel di bawah lampu Wood (hanya untuk M. canis dan hanya sebagai skrining).

Tanda darurat: Tidak ada tanda darurat spesifik yang terverifikasi.

Penanganan inti: Kombinasi antijamur sistemik dan bilasan topikal seluruh tubuh, isolasi, serta dekontaminasi lingkungan, dilanjutkan sampai kesembuhan klinis dan mikologis (kultur atau PCR negatif), bukan hanya sampai lesi hilang.

Pencegahan inti: Tidak ada vaksin yang direkomendasikan; periksa dan karantina kucing

baru sebelum digabung, jangan berbagi peralatan grooming, jaga kebersihan lingkungan, dan cuci tangan serta pakai sarung tangan saat menangani kucing terinfeksi.

Peringatan penting: Jangan memakai obat topikal atau oral manusia tanpa arahan dokter hewan, dan jangan mencukur seluruh tubuh (lion-clip) karena dapat menyebarkan infeksi ke area kulit yang belum terinfeksi.

Sumber utama: European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-dermatophytosis-ringworm-in-cats/); Merck Veterinary Manual (https://www.msdvetmanual.com/integumentary-system/dermatophytosis/dermatophytosis-in-dogs-and-cats?ruleredirectid=463ruleredirectid=458); UC Davis School of Veterinary Medicine (https://healthtopics.vetmed.ucdavis.edu/health-topics/ringworm-cats-dermatophytosis)

Entri 14 — Toksoplasmosis (Infeksi *Toxoplasma gondii*)

Apa itu: Penyakit akibat infeksi parasit Toxoplasma gondii, yang pada kucing sebagian besar bersifat subklinis; kucing adalah satu-satunya inang definitif tempat parasit bereproduksi secara seksual dan menghasilkan oosista.

Ciri-ciri umum: Sebagian besar kucing terinfeksi tidak bergejala; pada kucing yang sakit secara klinis, gejala paling umum menurut Cornell adalah demam, kehilangan nafsu makan, dan lesu. Gejala lain yang tercantum meliputi diare, batuk, kesulitan bernapas, penyakit kuning, kejang, serta radang mata dan gangguan saraf sesuai organ yang terkena.

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; kecurigaan meningkat pada kombinasi uveitis, tanda neurologis, pembesaran kelenjar getah bening mesenterika, pneumonia atau dispnea, nyeri otot, dan pincang, terutama pada kucing imunokompromais atau anak kucing.

Tanda darurat: Kesulitan bernapas yang memburuk, kejang, kebutaan atau gangguan mata mendadak, ikterus, demam disertai lesu berat dan tidak mau makan, serta ataksia atau kehilangan kontrol buang air.

Penanganan inti: Infeksi subklinis umumnya tidak diobati; kucing sakit klinis diobati dengan klindamisin sebagai pilihan utama, dikombinasikan dengan kortikosteroid bila ada radang mata atau sistem saraf pusat yang signifikan, ditambah perawatan pendukung seperti antikonvulsan dan cairan bila diperlukan; obat tidak memberantas infeksi sepenuhnya sehingga penyakit dapat kambuh.

Pencegahan inti: Beri makanan komersial atau yang dimasak sampai matang dan jangan beri daging mentah, cegah berburu dan pelihara kucing di dalam rumah, ganti litter setiap hari, dan ibu hamil serta orang imunokompromais sebaiknya tidak membersihkan kotak pasir; tidak ada vaksin.

Peringatan penting: Glukokortikoid dosis tinggi justru dapat mereaktivasi infeksi laten, sehingga penggunaannya harus atas keputusan dokter hewan.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/toxoplasmosis-cats); European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-toxoplasma-gondii-infection/); MSD Veterinary Manual (https://www.msdvetmanual.com/infectious-diseases/toxoplasmosis/toxoplasmosis-in-animals)

Entri 15 — Giardiasis (Infeksi *Giardia duodenalis*)

Apa itu: Infeksi usus halus oleh protozoa Giardia duodenalis; mayoritas kucing terinfeksi tidak menunjukkan gejala tetapi dapat mengeluarkan kista dan menulari kucing lain.

Ciri-ciri umum: Diare akut, kronis, atau kambuh-kambuh yang berbau sangat busuk, kadang berlemak, kehijauan, berlendir, atau berdarah, disertai penurunan berat badan bertahap, lesu, dan nafsu makan menurun. Muntah dan perut kembung juga dilaporkan tetapi lebih jarang, dan banyak kucing terinfeksi tidak bergejala sama sekali.

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; petunjuk yang mengarahkan adalah diare usus halus kronis atau intermiten — feses cair atau semi-cair bervolume relatif besar, berbau sangat busuk, dan kadang berlemak — disertai penurunan berat badan bertahap sementara nafsu makan sering masih ada.

Tanda darurat: Tidak ada tanda darurat spesifik yang terverifikasi.

Penanganan inti: Kucing tanpa gejala umumnya tidak dianjurkan diobati; kucing bergejala diobati dengan antiprotozoa atas resep dokter hewan (fenbendazol sebagai lini pertama menurut ABCD, metronidazol sebagai alternatif), disertai perawatan suportif bila dehidrasi atau diare berat, mandi pada hari terakhir pengobatan, dan tes feses ulang setelah pengobatan.

Pencegahan inti: Buang feses dan bersihkan litter box setiap hari, disinfeksi permukaan, jaga lingkungan sekering mungkin, beri air minum bersih dan cegah minum dari

genangan, serta mandikan kucing pada hari terakhir pengobatan; tidak ada vaksin.

Peringatan penting: Metronidazol tidak boleh digunakan pada induk hamil, dan kucing tanpa gejala umumnya tidak dianjurkan diobati karena risiko resistensi.

Sumber utama: European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-giardiasis/); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/giardia-in-cats); Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/gastrointestinal-parasites-cats)

Entri 16 — Cacingan (Infeksi cacing usus)

Apa itu: Infeksi saluran cerna oleh cacing parasit — gelang, tambang, pita, dan cambuk — yang hidup di usus, memakan makanan atau darah inang, dan mengeluarkan telur atau segmen tubuh lewat feses; banyak infeksi sering tanpa gejala.

Ciri-ciri umum: Gejalanya tidak spesifik dan tumpang tindih antar jenis cacing: muntah (kadang memuntahkan cacing), diare berlendir atau berdarah, perut buncit, bulu kusam, nafsu makan dan berat badan menurun, lesu, serta gusi pucat. Infeksi ringan dan banyak kucing dewasa sering tanpa gejala sama sekali.

Tanda khas: Tidak ada satu gejala patognomonik; cacing putih panjang seperti spageti yang dimuntahkan atau keluar lewat feses mengarah ke cacing gelang, segmen pipih seperti butir beras di feses atau sekitar anus mengarah ke cacing pita, dan feses hitam pekat lengket disertai gusi pucat dan lemas mengarah ke cacing tambang berat.

Tanda darurat: Anemia berat (gusi sangat pucat atau putih, lemas berat, kolaps), kehilangan darah berlebihan, sumbatan usus, dan dehidrasi berat akibat muntah atau diare berkepanjangan.

Penanganan inti: Obat cacing yang sesuai jenis cacing atas resep dokter hewan, diulang karena kebanyakan obat tidak membunuh tahap larva, disertai pengendalian sumber reinfeksi (kutu, mangsa, lingkungan), transfusi darah pada anemia berat yang jarang, dan pemeriksaan feses ulang.

Pencegahan inti: Obat cacing rutin (jadwal berbeda antara pedoman CAPC dan ESCCAP, misalnya anak kucing mulai usia 2 minggu menurut CAPC dan 3 minggu menurut ESCCAP, lalu diulang tiap 2 minggu pada masa awal), buang feses setiap hari, kendalikan kutu dan mangsa, hindari daging mentah, dan

pemeriksaan feses rutin.

Peringatan penting: Jangan memberikan obat cacing anjing ke kucing dan jangan menebak dosis dari internet.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/gastrointestinal-parasites-cats); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/internal-parasites-in-cats); Merck Veterinary Manual (https://www.msdvetmanual.com/multimedia/table/gastrointestinal-parasites-of-cats)

Entri 17 — Dermatitis alergi kutu (Flea allergy dermatitis, FAD)

Apa itu: Reaksi hipersensitivitas (alergi) terhadap antigen dalam air liur kutu yang disuntikkan saat kutu mengisap darah, bukan infestasi kutu itu sendiri; kucing yang tersensitisasi bisa sangat gatal hanya dari satu atau sedikit gigitan.

Ciri-ciri umum: Gatal hebat yang membuat kucing menggaruk, menggigit, atau menjilati berlebihan (sering tampak sebagai overgrooming), disertai rambut rontok terutama di pangkal ekor, leher, kepala, dan kaki. Kulit memerah dan meradang dengan benjolan kecil berkrusta, koreng, atau luka terbuka akibat garukan, yang dapat berlanjut menjadi infeksi kulit sekunder.

Tanda khas: Tidak ada satu gejala patognomonik; gatal sangat hebat yang tidak proporsional dengan jumlah kutu (bahkan ketika kutu tidak ditemukan karena dijilati sampai hilang), lesi terutama di punggung, pangkal ekor, paha belakang, selangkangan, kepala, dan leher, serta papul berkrusta kecil (miliary dermatitis).

Tanda darurat: Gusi pucat, lemas nyata, napas cepat, atau kolaps (mengarah ke anemia berat, terutama pada anak kucing), serta luka kulit luas yang bernanah, berbau, membengkak, atau sangat nyeri (mengarah ke infeksi bakteri sekunder berat).

Penanganan inti: Kontrol kutu yang ketat dan berkelanjutan pada kucing, semua hewan serumah, dan lingkungan sebagai pengobatan penyebab yang wajib, ditambah obat gatal atau anti-inflamasi atas resep dokter hewan sebagai pendukung (bukan pengganti kontrol kutu) dan antibiotik bila ada infeksi kulit sekunder.

Pencegahan inti: Kontrol kutu sepanjang tahun dan seumur hidup pada semua hewan serumah, kelola lingkungan dengan vakum rutin dan cuci alas tidur, serta

jangan menghentikan produk setelah infestasi tampak hilang karena eliminasi total dapat memakan waktu sampai 3 bulan.

Peringatan penting: Jangan pernah memakai produk kutu anjing pada kucing karena risiko permetrin yang mematikan.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (http://vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/flea-allergy); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/allergy-flea-allergy-in-cats); Companion Animal Parasite Council (CAPC) (https://capcvet.org/guidelines/fleas/)

Entri 18 — Tungau telinga (Otodectic mange, infestasi *Otodectes cynotis*)

Apa itu: Infestasi kanal telinga luar oleh tungau permukaan mikroskopis Otodectes cynotis yang tidak menggali kulit, melainkan hidup di permukaan kanal telinga dan memakan debris epidermis serta serumen; infestasi ini sering menyebabkan otitis eksterna.

Ciri-ciri umum: Gatal telinga hebat dengan garukan dan gelengan kepala, telinga dipegang datar, serta kotoran telinga gelap, berlilin, berkrusta, dan berbau tidak sedap seperti ampas kopi. Kanal dan daun telinga memerah, meradang, dan nyeri bila disentuh, dengan luka garukan dan rambut rontok di sekitar telinga; sebagian kucing hanya sedikit atau tanpa gejala.

Tanda khas: Tidak ada satu gejala yang memastikan diagnosis tanpa pemeriksaan dokter hewan; kombinasi gatal sangat hebat dengan garukan dan gelengan kepala, kotoran telinga kering berkrusta cokelat gelap seperti ampas kopi (sering di kedua telinga), dan bintik putih kecil yang bergerak bila terlihat.

Tanda darurat: Daun telinga tiba-tiba bengkak lunak berisi cairan (curiga hematoma aural), perdarahan telinga yang banyak atau terus-menerus, kepala miring menetap atau kehilangan keseimbangan, penurunan pendengaran nyata atau nyeri hebat, serta kejang atau kolaps (bukan gejala khas tungau sehingga wajib dievaluasi darurat untuk penyebab lain).

Penanganan inti: Pembersihan telinga menyeluruh di awal, akarisida atas resep dokter hewan (lakton makrosiklik atau isoksazolin; sistemik lebih disukai bila ada tungau di luar telinga), pengobatan semua hewan serumah termasuk yang tanpa gejala, pengobatan infeksi sekunder bila ada, dan kontrol ulang karena obat tidak menembus telur.

Pencegahan inti: Obati semua hewan serumah secara bersamaan bila satu hewan terinfestasi, batasi paparan ke hewan tidak dikenal, gunakan antiparasit pencegahan berlabel sesuai resep dokter hewan, dan periksa telinga secara berkala; tidak ada vaksin tungau telinga.

Peringatan penting: Jangan membersihkan telinga dengan hidrogen peroksida atau cuka, jangan memasukkan cotton bud jauh ke kanal, dan jangan menusuk hematoma sendiri di rumah.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/ear-mites-tiny-critters-can-pose-major-threat); Western College of Veterinary Medicine (https://wcvm.usask.ca/learnaboutparasites/parasites/otodectes-cynotis.php); Companion Animal Parasite Council (CAPC) (https://capcvet.org/guidelines/otodectic-mite/)

Entri 19 — Jerawat kucing (Feline acne)

Apa itu: Gangguan keratinisasi folikel rambut di dagu (dan bibir) yang penyebab pastinya tidak diketahui; bentuk paling umum dan ringan hanyalah komedo tanpa gejala, tetapi sebagian kasus berlanjut menjadi folikulitis atau furunkulosis bakteri sekunder yang nyeri.

Ciri-ciri umum: Dagu tampak kotor karena komedo kecil dan krusta tanpa gejala pada kasus ringan, terutama di dagu dan bibir bawah. Bila meradang atau terinfeksi sekunder, dagu dan bibir membengkak dan memerah disertai kerontokan bulu, papul, krusta, atau pustul, dan kucing dapat menggosok atau menggaruk dagunya.

Tanda khas: Komedo hitam kecil di dagu atau bibir yang tampak seperti kotoran yang tidak hilang saat dibersihkan adalah ciri khasnya, dengan lesi yang sangat terbatas di dagu dan bibir; nyeri menunjukkan sudah terjadi furunkulosis, tetapi tidak ada satu gejala yang 100% spesifik.

Tanda darurat: Tidak ada tanda darurat spesifik yang terverifikasi. Segera periksakan bila dagu atau bibir membengkak dan nyeri, lesi bernanah, berdarah, mengeluarkan cairan, atau menyebar, kucing kesakitan atau berhenti makan, atau lesi tidak membaik dan kambuh berulang.

Penanganan inti: Kasus ringan (komedo tanpa gejala) biasanya tidak memerlukan pengobatan, cukup pantau dan jaga kebersihan dagu; kasus meradang diobati dengan pembersihan dan produk topikal atas arahan dokter hewan,

serta antibiotik bila ada infeksi bakteri sekunder dan kortikosteroid untuk peradangan berat.

Pencegahan inti: Ganti mangkuk plastik ke kaca, keramik, atau baja nirkarat yang halus dan cuci setiap hari, bersihkan dagu setiap hari (terutama setelah makanan kaleng), dan lanjutkan pembersihan 2–3 kali seminggu sebagai pemeliharaan setelah remisi; penyebab sering tidak diketahui sehingga pencegahan total tidak dijamin.

Peringatan penting: Jangan memencet lesi, dan jangan memakai produk jerawat manusia tanpa arahan dokter hewan karena berpotensi sangat mengiritasi dan memperburuk keadaan.

Sumber utama: VCA Canada Animal Hospitals (https://vcacanada.com/know-your-pet/pet-health-articles/chin-acne-in-cats); Cornell University College of Veterinary Medicine, CatWatch (https://www.catwatchnewsletter.com/health/medicine/monitoring-feline-acne/); University of Minnesota (https://open.lib.umn.edu/animaldermatology2/chapter/idiopathic-keratinization-disorders-feline-acne/)

Entri 20 — Penyakit gigi dan gusi (Periodontal disease, gingivitis, stomatitis, resorpsi gigi)

Apa itu: Payung penyakit mulut — terutama gingivitis, periodontitis, dan resorpsi gigi, dengan stomatitis kronis sebagai bentuk radang luas yang terkait tetapi berbeda — yang penyebab utamanya adalah plak bakteri yang mengeras menjadi tartar; gingivitis masih reversibel sedangkan periodontitis ireversibel tetapi dapat distabilkan.

Ciri-ciri umum: Bau mulut tidak sedap, gusi merah, bengkak, nyeri, dan mudah berdarah, air liur berlebihan kadang bercampur darah, serta enggan atau sulit makan, menjatuhkan makanan, dan memilih makanan lunak. Gigi goyang atau hilang, tartar yang terlihat, serta penurunan nafsu makan, berat badan, dan grooming juga umum, tetapi banyak kucing tidak menunjukkan gejala yang dapat dikenali pemilik.

Tanda khas: Lokasi dan luas radang menjadi pembeda utama: gingivitis terbatas pada gusi (merah, bengkak, berdarah saat disentuh, gigi belum goyang); periodontitis disertai resesi gusi, kantong gusi, dan gigi goyang; resorpsi ditandai defek merah muda pada gigi tepat di garis gusi yang sangat nyeri; stomatitis meluas ke seluruh selaput lendir mulut dengan nyeri ekstrem; abses akar ditandai pembengkakan wajah, terutama di bawah mata.

Tanda darurat: Tidak bisa atau tidak mau makan atau minum sama sekali, perdarahan mulut

yang banyak dan tidak berhenti, pembengkakan wajah yang cepat membesar, mulut tidak bisa dibuka atau ditutup, nanah yang mengalir dari gusi atau dari bawah mata atau dagu, serta kesulitan bernapas atau menelan.

Penanganan inti: Pembersihan profesional di bawah anestesi (scaling supra- dan subgingiva serta polishing), pencabutan gigi pada periodontitis lanjut, stomatitis berat, atau abses akar (antibiotik dan pereda nyeri hanya mengendalikan gejala abses, bukan menyembuhkannya), serta menyikat gigi setiap hari dengan pasta khusus kucing dan makanan lunak selama masa nyeri atau setelah pencabutan.

Pencegahan inti: Menyikat gigi setiap hari dengan pasta khusus kucing sebagai standar emas (minimal 3 kali seminggu menurut VCA), diet gigi khusus atau produk berlabel VOHC atas rekomendasi dokter hewan, serta pemeriksaan gigi rutin (minimal setahun sekali, tiap 3–6 bulan bila pernah bermasalah); makanan kering standar tidak boleh diklaim membersihkan gigi, dan resorpsi sebagian besar tidak dapat dicegah.

Peringatan penting: Jangan menyikat gigi kucing dengan gingivitis berat karena sangat nyeri (konsultasikan dulu dengan dokter hewan), jangan memakai pasta gigi manusia atau soda kue, dan jangan mengandalkan pembersihan tanpa anestesi karena tidak mengobati plak di bawah garis gusi.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/feline-dental-disease); MSD Veterinary Manual (https://www.msdvetmanual.com/cat-owners/digestive-disorders-of-cats/dental-disorders-of-cats?query=dental); International Cat Care (https://icatcare.org/articles/dental-disease-in-cats)

Entri 21 — Lipidosis hepatik (Feline hepatic lipidosis)

Apa itu: Lipidosis hepatik felin adalah penyakit hati berlemak paling umum dan berpotensi fatal pada kucing, ketika lemak tubuh yang dimobilisasi berlebihan menumpuk sebagai trigliserida di sel hati hingga fungsi hati gagal, yang dipicu terutama oleh anoreksia berkepanjangan.

Ciri-ciri umum: Tidak makan, turun berat dramatis (lebih dari 25%), lesu dan lemah, disertai muntah serta ikterus (kuning pada mata, gusi, dan kulit). Kucing juga tampak menyendiri, menghindari mangkuk makan, dan dapat berliur berlebihan, dengan diare atau konstipasi yang lebih jarang.

Tanda khas: Tidak ada satu gejala patognomonik; pembedanya adalah kombinasi kucing yang sebelumnya gemuk, lalu tidak makan berhari-hari hingga berminggu-minggu dan turun berat cepat, disertai ikterus, hati membesar tanpa nyeri, dan pola lab ALP jauh lebih tinggi daripada GGT.

Tanda darurat: Tidak makan 3–4 hari (terutama kucing yang gemuk), ikterus nyata, muntah berulang, dehidrasi, kelemahan ekstrem hingga tidak bisa berdiri, sesak, atau kolaps.

Penanganan inti: Dukungan nutrisi adalah terapi spesifiknya, dimulai bertahap lewat selang makan setelah hidrasi dan elektrolit diperbaiki; ditambah koreksi cairan/elektrolit, vitamin K1 dan vitamin B, serta pengobatan penyakit penyebab anoreksia.

Pencegahan inti: Pantau asupan makan setiap hari dan segera ke dokter hewan bila nafsu makan menurun; jaga berat badan sehat dengan penurunan bertahap di bawah pengawasan dokter hewan, dan kelola stres lingkungan.

Peringatan penting: Jangan memuasakan kucing (terutama yang gemuk) untuk menurunkan berat badan, dan jangan memaksa makan lewat mulut karena risiko pneumonia aspirasi.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/hepatic-lipidosis); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/liver-disease-fatty-liver-syndrome-in-cats%23); MSD Veterinary Manual (https://www.msdvetmanual.com/digestive-system/hepatic-diseases-of-small-animals/feline-hepatic-lipidosis?mredirectid=1158)

Entri 22 — Pankreatitis (Pancreatitis)

Apa itu: Pankreatitis kucing adalah radang pankreas, akut atau kronis, yang terjadi ketika enzim pencernaan teraktivasi terlalu dini di dalam pankreas dan "mencerna" pankreas itu sendiri, dan pada lebih dari 95% kasus penyebabnya tidak dapat ditentukan.

Ciri-ciri umum: Gejalanya variabel, sering samar, dan tidak spesifik, dengan yang paling konsisten adalah nafsu makan menurun sampai menolak makan, lesu, muntah atau mual, diare, penurunan berat badan, dan dehidrasi. Dapat pula muncul demam atau suhu tubuh rendah, nyeri perut, dan ikterus, sedangkan bentuk kronis gejalanya hilang-timbul.

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; yang mengarahkan kecurigaan adalah dominasi anoreksia dan letargi dengan muntah/nyeri yang kurang menonjol (berbeda dari anjing), kadang ikterus, dan perjalanan kronis berulang.

Tanda darurat: Syok akut pada serangan berat; tidak ada daftar darurat baku yang terverifikasi.

Penanganan inti: Tidak ada obat spesifik; perawatan suportif berupa cairan, anti-mual, pereda nyeri, dan dukungan nutrisi dini (bukan puasa berkepanjangan), dengan rawat inap untuk kasus berat.

Pencegahan inti: Tidak ada pencegahan spesifik yang terverifikasi; yang dapat dilakukan hanyalah perawatan kesehatan umum (berat badan sehat, diet berkualitas, pemeriksaan rutin), bukan pencegahan pankreatitis yang terbukti.

Peringatan penting: Jangan memuasakan kucing berkepanjangan dan jangan memaksa kucing makan; puasa total hanya bila kucing muntah meski sudah diberi obat anti-mual.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/feline-pancreatitis); VCA Hospitals (https://vcacanada.com/know-your-pet/pancreatitis-in-cats); International Cat Care (https://icatcare.org/articles/pancreatitis-in-cats)

Entri 23 — Kardiomiopati hipertrofik (Feline hypertrophic cardiomyopathy)

Apa itu: Kardiomiopati hipertrofik (HCM) adalah penyakit jantung paling umum pada kucing, ketika otot jantung — terutama ventrikel kiri — menebal dan menjadi kaku sehingga sulit mengendur dan terisi darah.

Ciri-ciri umum: Banyak kucing dengan penyakit ringan–sedang tampak tidak sakit sama sekali. Bila gejala muncul, yang terverifikasi adalah napas berat, cepat, atau lewat mulut, letargi, nafsu makan menurun, cepat lelah atau intoleransi olahraga, kelemahan, dan episode kolaps atau pingsan.

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; yang membantu adalah murmur/gallop pada kucing yang tampak sehat, sesak napas dengan laju napas istirahat di atas 35×/menit, dan "5 P" FATE (nyeri hebat, kelumpuhan kaki, denyut hilang, kaki dingin, bantalan kaki pucat).

Tanda darurat: Napas cepat saat istirahat/tidur di atas 35×/menit secara konsisten, napas

berat atau lewat mulut, kelumpuhan/kelemahan kaki mendadak disertai nyeri hebat dan kaki dingin, serta kolaps atau pingsan.

Penanganan inti: Tidak ada obat yang menyembuhkan; tanpa gejala dan risiko rendah sering cukup dipantau, sedangkan gagal jantung ditangani dengan oksigen, diuretik, dan obat jantung, dan risiko bekuan ditangani dengan obat anti-bekuan — semuanya atas arahan dokter hewan.

Pencegahan inti: Tidak ada pencegahan atau vaksin yang dapat menjamin; yang terverifikasi adalah skrining ekokardiografi (terutama ras berisiko dan kucing pembiak), tidak membiakkan kucing yang terbukti HCM, dan pemeriksaan rutin.

Peringatan penting: Jangan memberi aspirin, diuretik, beta-blocker, atau obat jantung manusia tanpa resep dokter hewan, dan jangan menghentikan obat jantung mendadak.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/hypertrophic-cardiomyopathy); International Cat Care (https://icatcare.org/articles/cardiomyopathy-heart-disease-in-cats); PDSA (https://www.pdsa.org.uk/pet-help-and-advice/pet-health-hub/conditions/hcm-hypertrophic-cardiomyopathy-in-cats)

Entri 24 — Infeksi Chlamydia felis (Feline chlamydiosis)

Apa itu: Infeksi Chlamydia felis adalah infeksi bakteri intraseluler obligat yang terutama menyerang konjungtiva mata kucing dan menyebabkan konjungtivitis, biasanya mulai satu mata lalu menjadi dua mata.

Ciri-ciri umum: Gejala didominasi mata: konjungtivitis dengan mata merah dan bengkak, leleran yang awalnya encer lalu menjadi mukopurulen kuning atau hijau, serta kucing menyipit atau sering berkedip, biasanya mulai satu mata lalu menjadi dua mata dalam beberapa hari. Gejala pernapasan atas ringan dapat menyertai, berupa bersin, leleran hidung, dan napas berbunyi, dengan demam sementara dan lesu yang umumnya ringan.

Tanda khas: Konjungtivitis dominan dengan gejala pernapasan minimal, mulai satu mata lalu menjadi dua mata, kemosis (pembengkakan konjungtiva seperti jelly) yang mencolok, dan kornea biasanya tidak terlibat (adanya ulkus kornea justru mengarah ke FHV-1).

Tanda darurat: Tidak ada tanda darurat spesifik yang terverifikasi.

Penanganan inti: Antibiotik doksisiklin sistemik sebagai utama, dengan rentang durasi 3–6 minggu menurut sumber dan acuan ABCD minimal 4 minggu yang dilanjutkan setelah gejala hilang; obati semua kucing serumah dan pisahkan kucing sakit.

Pencegahan inti: Vaksin non-core berbasis risiko (tidak mencegah infeksi sepenuhnya, hanya mengurangi keparahan); pisahkan kucing sakit, obati seluruh rumah, dan jaga higiene dengan deterjen/disinfektan umum.

Peringatan penting: Jangan menghentikan antibiotik begitu mata tampak membaik; pengobatan harus dilanjutkan setelah gejala hilang sesuai arahan dokter hewan.

Sumber utama: ABCD (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-chlamydia-felis/); MSD Veterinary Manual (https://www.msdvetmanual.com/cat-owners/eye-disorders-of-cats/chlamydial-conjunctivitis-in-cats-feline-pneumonitis?ruleredirectid=458); International Cat Care (https://icatcare.org/articles/chlamydia-infection-in-cats)

Entri 25 — Bordetelosis felin (Infeksi Bordetella bronchiseptica)

Apa itu: Bordetelosis felin adalah infeksi bakteri Bordetella bronchiseptica pada saluran pernapasan kucing, yang menyebabkan radang trakea dan bronkus dengan gejala menyerupai flu kucing.

Ciri-ciri umum: Bersin, batuk, leleran hidung dan mata, demam, serta pembesaran kelenjar getah bening, dengan gejala yang umumnya berlangsung 7–10 hari. Pada bentuk berat dapat muncul lesu, tidak mau makan, dan sesak napas.

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; yang mengarahkan kecurigaan adalah batuk yang menonjol (akut maupun kronis), kadang disertai limfadenopati, pada kucing dari shelter/cattery/rumah multi-kucing atau yang kontak dengan anjing penderita batuk kennel.

Tanda darurat: Kesulitan bernapas/sesak napas, membran mukosa kebiruan (sianosis), dan pneumonia yang mengancam jiwa, terutama pada anak kucing sangat muda.

Penanganan inti: Antibiotik (pilihan pertama doksisiklin bila data kepekaan belum tersedia) dengan dasar uji kepekaan bila tersedia; kasus berat memerlukan cairan intravena, oksigen, dan rawat inap.

Pencegahan inti: Vaksin non-core intranasal hanya untuk kucing di populasi padat berisiko (bukan rutin); kurangi kepadatan, bersihkan dan disinfeksi lingkungan, dan isolasi kucing sakit.

Peringatan penting: Jangan pernah berikan vaksin Bordetella hidup intranasal pada anak kucing di bawah 4 minggu atau kucing yang sedang/akan menerima antibiotik; kucing yang divaksinasi dapat menumpahkan bakteri hingga satu tahun, sehingga vaksin hidup harus dihindari bila ada kontak dekat dengan manusia immunocompromised.

Sumber utama: ABCD (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-bordetella-bronchiseptica-infection-in-cats/); Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/respiratory-infections); International Cat Care (https://icatcare.org/articles/bordetella-bronchiseptica-infection-in-cats)

Entri 26 — Hemoplasmosis felin (Infeksi Mycoplasma haemofelis)

Apa itu: Hemoplasmosis felin adalah infeksi bakteri Mycoplasma haemofelis yang menempel di permukaan sel darah merah dan dapat memicu anemia hemolitik, dari tanpa gejala sampai berat dan kadang fatal.

Ciri-ciri umum: Gejalanya tidak spesifik dan mencerminkan anemia: lemas, lesu, cepat lelah, nafsu makan menurun, penurunan berat badan, dehidrasi, dan demam yang sering intermiten. Gusi dan selaput lendir mata tampak pucat sampai putih, kadang menguning (ikterus, yang menurut ABCD tidak umum), serta dapat terjadi pembesaran limpa atau kelenjar getah bening.

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; pembedanya adalah kombinasi anemia hemolitik regeneratif dengan demam intermiten, organisme yang terlihat menempel di permukaan eritrosit, dan PCR positif spesifik M. haemofelis — gusi pucat saja bukan pembeda.

Tanda darurat: Gusi/selaput lendir sangat pucat sampai putih atau menguning jelas, lemas berat, napas cepat/sesak, dan denyut jantung sangat cepat sebagai tanda anemia berat.

Penanganan inti: Antibiotik doksisiklin lini pertama; koreksi dehidrasi dengan cairan, rangsang nafsu makan atau beri makan bantuan, oksigen bila perlu, dan transfusi darah bila anemia sangat berat.

Pencegahan inti: Tidak ada vaksin; pengendalian kutu dan caplak sebagai kewaspadaan (bukan jaminan), kurangi perkelahian antar kucing, pertimbangkan kucing indoor, dan skrining PCR semua donor darah.

Peringatan penting: Kortikosteroid tidak dianjurkan menurut ABCD 2026 kecuali kondisi khusus; enrofloksasin bukan pilihan karena potensi toksisitas retina ireversibel; tablet doksisiklin harus selalu diikuti makanan atau air karena risiko esofagitis.

Sumber utama: ABCD (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-haemoplasmosis-in-cats/?pdf=5116); VCA Animal Hospitals (https://vcacanada.com/know-your-pet/feline-hemotrophic-mycoplasmosis); Tasker et al., Journal of Feline Medicine and Surgery 2018 (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10816291/)

Entri 27 — Koksidiosis (Infeksi Cystoisospora)

Apa itu: Koksidiosis kucing adalah infeksi usus oleh protozoa Cystoisospora (dahulu Isospora), terutama C. felis dan C. rivolta, yang sebagian besar tidak bergejala kecuali pada anak kucing dan kucing yang lemah.

Ciri-ciri umum: Sebagian besar kucing yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala sama sekali. Bila bergejala, yang paling umum adalah diare berair atau berlendir (pada kasus berat dapat berdarah belakangan), disertai dehidrasi, nyeri atau gangguan perut, nafsu makan menurun, muntah, dan penurunan berat badan atau pertumbuhan buruk.

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; yang mendukung kecurigaan adalah diare usus besar hingga campuran pada anak kucing (di bawah 6 bulan, terutama 4–12 minggu) dari lingkungan padat, dengan oosista dalam jumlah besar pada flotasi feses.

Tanda darurat: Diare berat/berdarah yang menetap, dehidrasi, muntah, tidak mau makan/minum, kelemahan berat, dan penurunan berat badan — terutama pada anak kucing yang dapat memburuk cepat.

Penanganan inti: Banyak infeksi sembuh spontan; kasus bergejala diobati dengan antikoksidia (misalnya sulfadimethoxine atau ponazuril yang bersifat off-label), plus menjaga kucing tetap hangat dan terhidrasi.

Pencegahan inti: Kebersihan ketat: buang feses sesegera mungkin, disinfeksi area/kandang/peralatan setiap hari, jangan beri daging mentah, dan kendalikan serangga serta hewan pengerat.

Peringatan penting: Obat cacing biasa tidak mengobati koksidiosis karena koksidia bukan cacing; disinfektan amonia tidak boleh dipakai saat hewan ada di tempat.

Sumber utama: VCA Canada (https://vcacanada.com/know-your-pet/coccidiosis-in-cats); Merck Veterinary Manual (https://www.merckvetmanual.com/digestive-system/coccidiosis/coccidiosis-of-cats-and-dogs?ruleredirectid=19); Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/gastrointestinal-parasites-cats)

Entri 28 — Kriptosporidiosis (Infeksi Cryptosporidium)

Apa itu: Kriptosporidiosis kucing adalah infeksi usus oleh protozoa Cryptosporidium, terutama C. felis, yang sering subklinis tetapi dapat menyebabkan diare persisten pada anak kucing dan kucing immunocompromised.

Ciri-ciri umum: Sering tanpa gejala sama sekali. Bila bergejala, tanda utamanya adalah diare encer (usus halus atau campuran) yang dapat intermiten dan berlangsung lama, disertai dehidrasi, penurunan berat badan, nafsu makan menurun, muntah, demam, dan kram perut.

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; petunjuknya adalah diare usus halus atau campuran yang intermiten dan berlarut, terutama pada anak kucing atau kucing immunocompromised, dengan oosista sangat kecil (4–6 µm) yang hanya terdeteksi lewat pewarnaan khusus atau PCR.

Tanda darurat: Tidak ada tanda darurat spesifik yang terverifikasi.

Penanganan inti: Tidak ada obat yang terbukti konsisten mengeliminasi parasit; kucing tanpa gejala mungkin tidak perlu diobati, sedangkan kasus berat/persisten ditangani atas arahan dokter hewan (misalnya azitromisin pada anak kucing) plus rehidrasi, diet mudah cerna, dan pengobatan penyakit yang mendasari.

Pencegahan inti: Tidak ada vaksin dan obat pencegahan andal; segera buang feses, bersihkan dengan panas/uap lalu keringkan, cegah kontaminasi pakan dan air, dan cuci tangan dengan sabun dan air.

Peringatan penting: Klorin/pemutih biasa tidak dapat diandalkan membunuh oosista; jangan mencampur pemutih dengan bahan kimia lain, dan hand sanitizer alkohol umumnya tidak efektif terhadap parasit ini.

Sumber utama: Companion Animal Parasite Council (CAPC) (https://capcvet.org/guidelines/cryptosporidium/); Western College of

Veterinary Medicine (https://wcvm.usask.ca/learnaboutparasites/parasites/cryptosporidium-species.php); Marks et al. via PMC (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7152495/)

Entri 29 — Tritrichomoniasis felin (Infeksi Tritrichomonas blagburni)

Apa itu: Tritrichomoniasis felin adalah infeksi usus besar oleh protozoa berflagela Tritrichomonas blagburni (dahulu disebut T. foetus) yang menyebabkan diare usus besar kronis.

Ciri-ciri umum: Diare usus besar kronis atau hilang-timbul yang dapat berlangsung berbulan-bulan, dengan frekuensi buang air meningkat tetapi jumlah feses per episode sering sedikit, feses sangat berbau busuk, berlendir dan/atau berdarah segar, disertai mengejan, kembung, inkontinensia feses, dan iritasi daerah anus. Umumnya kucing tetap dalam kondisi tubuh yang cukup baik tanpa gejala sistemik yang menonjol.

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; kombinasinya adalah diare usus besar kronis hilang-timbul yang berbau sangat busuk, berisi lendir dan/atau darah segar, disertai mengejan, sementara kucing tetap ceria, mau makan, dan tidak banyak kehilangan berat badan.

Tanda darurat: Tidak ada tanda darurat spesifik yang terverifikasi.

Penanganan inti: Obat pilihan ronidazole (tidak berlisensi untuk kucing, perlu persetujuan pemilik yang diinformasikan) dengan pengawasan ketat; diet sangat mudah cerna dan/atau tinggi serat dapat membantu, sedangkan metronidazole tidak efektif sebagai terapi utama.

Pencegahan inti: Tidak ada vaksin atau obat pencegahan spesifik; jaga higiene bak pasir dengan pengosongan dan pembersihan sering, pisahkan kucing terinfeksi dari yang tidak terinfeksi, dan kurangi kepadatan serta stres.

Peringatan penting: Jangan berikan ronidazole pada kucing hamil/menyusui atau berusia 12 minggu ke bawah; bila muncul letargi, hilang nafsu makan, sempoyongan, tremor, atau kejang, hentikan obat segera dan jangan memulai ulang.

Sumber utama: ABCD (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-trichomonosis/); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/tritrichomonas-in-cats); International Cat Care (https://icatcare.org/advice/tritrichomonas-foetus-infection-in-cats/)

Entri 30 — Sarkoma tempat suntikan (Feline injection-site sarcoma)

Apa itu: Sarkoma tempat suntikan felin (FISS) adalah tumor ganas jaringan ikat yang agresif secara lokal dan muncul di bekas suntikan/vaksinasi, sebagian besar berupa fibrosarkoma.

Ciri-ciri umum: Benjolan tunggal yang keras di bawah kulit, umumnya di flank, bahu, atau daerah interskapular, tampak berbatas tegas, tidak nyeri tekan yang menonjol, dan sering tidak mudah digerakkan. Pada tahap awal kucing sering tampak sehat selain benjolannya, dan gejala sistemik umumnya muncul belakangan atau bila tumor sudah besar atau menyebar.

Tanda khas: Tidak ada gejala tunggal yang membuktikan; pembedanya adalah benjolan keras dan melekat di bekas suntikan (interskapular, flank, tungkai) yang muncul berminggu-minggu hingga bertahun-tahun setelah suntikan, dan memenuhi aturan 3-2-1 (bertahan 3 bulan, diameter di atas 2 cm, atau membesar dalam 1 bulan).

Tanda darurat: Tidak ada tanda darurat spesifik yang terverifikasi.

Penanganan inti: Operasi radikal en bloc dengan margin lebar pada upaya pertama adalah tulang punggung terapi, sering ditambah radioterapi dan kadang imunoterapi; eksisi marginal sangat tidak dianjurkan.

Pencegahan inti: Bukan berhenti vaksinasi, melainkan vaksinasi individual sesering perlu sesedikit mungkin, di lokasi yang mudah dioperasi (hindari daerah interskapular), dan pantau setiap benjolan dengan aturan 3-2-1.

Peringatan penting: Jangan menghentikan vaksinasi karena takut sarkoma, karena risiko penyakit yang dicegah vaksin jauh lebih besar daripada risiko sarkoma yang sangat kecil; setiap benjolan yang memenuhi aturan 3-2-1 harus segera diperiksa, bukan ditunggu.

Sumber utama: ABCD (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-feline-injection-site-sarcoma/); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/post-vaccination-sarcoma-in-cats); Merck Veterinary Manual (https://www.merckvetmanual.com/integumentary-system/tumors-of-the-skin-and-soft-tissues/connective-tissue-tumors-in-animals?autoredirectid=14258)

Entri 31 — Limfoma (Feline lymphoma)

Apa itu: Kanker ganas limfosit (sel darah putih sistem imun) yang dapat menyerang satu area atau banyak organ sekaligus, dan merupakan kanker kucing yang paling sering

didiagnosis.

Ciri-ciri umum: Gejala umumnya tidak spesifik dan bergantung lokasi: penurunan berat badan, perubahan nafsu makan, lesu atau lemah, muntah, dan diare, kadang disertai demam, dehidrasi, dan pembesaran kelenjar getah bening yang dapat diraba. Bentuk gastrointestinal paling sering menimbulkan penurunan berat badan, muntah, dan diare, sedangkan bentuk dada menimbulkan sulit bernapas dan bentuk hidung menimbulkan cairan hidung serta bersin.

Tanda khas: Tidak ada satu gejala patognomonik; petunjuknya adalah pola per lokasi — sesak napas mendadak pada kucing muda dengan massa dada atau efusi pleura mengarah ke bentuk mediastinal, ginjal membesar bilateral yang memburuk cepat ke bentuk ginjal, dan cairan hidung kronis berdarah ke bentuk hidung; bentuk usus tumpang tindih total dengan IBD sehingga pembeda pastinya adalah biopsi.

Tanda darurat: Sesak napas berat atau napas mulut terbuka, obstruksi usus akibat massa, kejang, kolaps, muntah atau diare tak terkendali hingga dehidrasi, dan tidak mau makan total lebih dari 24–48 jam (laporan mencatat ini bukan daftar darurat formal Cornell/VCA, melainkan gejala yang harus segera dievaluasi).

Penanganan inti: Kemoterapi sebagai pengobatan utama dengan tujuan remisi dan kualitas hidup, bukan kesembuhan yang dijamin; bentuk usus sel kecil umumnya diobati dengan steroid oral plus obat kemoterapi oral di rumah, bentuk sel besar dengan protokol injeksi kombinasi, operasi hanya bila massa terlokalisir, dan radiasi terutama untuk bentuk hidung.

Pencegahan inti: Tidak ada pencegahan absolut; risiko dapat dikurangi dengan vaksinasi FeLV dan tes serta isolasi kucing FeLV/FIV-positif, menjaga kucing di dalam rumah, menghindari asap rokok, dan pemeriksaan rutin (dua kali setahun untuk kucing usia 7 tahun ke atas).

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/lymphoma); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/lymphoma-in-cats); Merck Veterinary Manual (https://www.merckvetmanual.com/cat-owners/blood-disorders-of-cats/white-blood-cell-disorders-leukemia-and-lymphoma-of-cats)

Entri 32 — Penyumbatan saluran kemih (Obstruksi uretra)

Apa itu: Sumbatan sebagian atau total pada uretra sehingga urine tidak dapat keluar normal; pada sumbatan total, urine tertahan, kandung kemih meregang berlebihan, dan

fungsi ginjal menurun hingga kematian.

Ciri-ciri umum: Mengejan saat berkemih, berkemih nyeri, sering bolak-balik ke litter box tetapi hanya keluar sedikit urine atau tidak sama sekali, darah dalam urine, berkemih di luar litter box, dan menjilat daerah genital secara berlebihan. Pada tahap lanjut muncul muntah, lesu berat, dehidrasi, lemah hingga tidak bisa berdiri, dan kolaps.

Tanda khas: Mengejan berulang tanpa urine keluar (atau hanya tetesan), terutama pada kucing jantan, ditambah kandung kemih yang keras, membesar, penuh, dan nyeri serta tidak dapat dikosongkan; perburukan sistemik cepat setelah 24 jam (muntah, lesu berat, kesadaran menurun) menandakan uremia dan hiperkalemia.

Tanda darurat: Mengejan berulang tanpa urine, bolak-balik ke litter box sambil mengeong kesakitan, perut keras atau membesar dan nyeri, darah dalam urine, serta muntah, lesu berat, lemah, tidak bisa berdiri, atau kolaps; kematian dapat terjadi dalam 24–72 jam sejak obstruksi total menurut rentang antar sumber.

Penanganan inti: Tindakan medis darurat di klinik — stabilisasi dengan cairan infus, pereda nyeri, koreksi hiperkalemia yang mengancam jiwa, dan pembebasan sumbatan lewat kateterisasi uretra di bawah sedasi berat atau anestesi umum; tidak ada penanganan rumahan yang terverifikasi untuk membuka sumbatan.

Pencegahan inti: Tidak ada pencegahan yang menjamin; risiko kekambuhan diturunkan dengan hidrasi dan diet urinari sesuai anjuran dokter hewan, pengurangan stres dan modifikasi lingkungan, berat badan sehat dan aktivitas, serta pemantauan litter box seumur hidup setelah satu episode.

Peringatan penting: Mengejan untuk berkemih sering disalahartikan sebagai konstipasi; kuncinya adalah memeriksa apakah urine benar-benar keluar, dan jangan mencoba membuka sumbatan sendiri di rumah — segera ke dokter hewan.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/feline-lower-urinary-tract-disease); Merck Veterinary Manual (https://www.merckvetmanual.com/urinary-system/urolithiasis-in-small-animals/urethral-obstruction-in-small-animals?ruleredirectid=434); MSPCA-Angell (https://www.mspca.org/clinical/urethral-obstruction-in-cats/)

Entri 33 — Batu saluran kemih (Urolithiasis)

Apa itu: Endapan mineral yang mengeras (urolit) di saluran kemih — ginjal, ureter, kandung kemih, atau uretra — yang terbentuk saat mineral urine mengendap menjadi kristal lalu tumbuh menjadi batu selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.

Ciri-ciri umum: Gejala paling konsisten adalah darah dalam urine, sulit dan nyeri saat berkemih, berkemih sering tetapi sedikit-sedikit, berkemih di luar kotak pasir, dan menjilat area genital, disertai lesu dan nafsu makan menurun. Batu ginjal biasanya tanpa gejala sampai menimbulkan masalah, sedangkan batu ureter dapat menimbulkan muntah, lesu, dan nyeri pinggang.

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; yang membedakan adalah kombinasi gejala saluran bawah yang persisten atau berulang dengan batu yang teraba atau terlihat di pencitraan, atau pola batu ginjal yang "diam" lalu tiba-tiba menimbulkan krisis ginjal; jenis batu yang pasti hanya diketahui lewat analisis batu itu sendiri, bukan dari urinalisis saja.

Tanda darurat: Obstruksi uretra total (mengejan tanpa urine, nyeri hebat, perut tegang, muntah, lesu) yang tanpa perawatan dapat berakibat fatal, serta obstruksi ureter bilateral total atau pada kucing dengan penyakit ginjal kronis yang dapat memicu krisis uremik.

Penanganan inti: Tergantung jenis, lokasi, dan ukuran batu — batu struvit steril umumnya dapat dilarutkan dengan diet resep, sedangkan batu kalsium oksalat tidak dapat dilarutkan dan harus dikeluarkan lewat pembedahan atau teknik invasif minimal; pelarutan batu urat pada kucing tidak konsisten sehingga pembedahan paling umum.

Pencegahan inti: Kekambuhan umum terjadi sehingga pencegahan bersifat jangka panjang — tingkatkan asupan air dan urine yang encer, diet terapeutik sesuai jenis batu (bukan satu diet untuk semua batu), pemeriksaan ulang berkala seumur hidup, dan kirim batu yang diangkat untuk analisis laboratorium.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/bladder-and-kidney-stones); Merck Veterinary Manual (https://www.merckvetmanual.com/urinary-system/urolithiasis-in-small-animals/overview-of-urolithiasis-in-small-animals); MSD Veterinary Manual (https://www.msdvetmanual.com/urinary-system/urolithiasis-in-small-animals/urolithiasis-in-cats)

Entri 34 — Megakolon (Feline megacolon)

Apa itu: Pelebaran kolon yang menetap disertai kehilangan kemampuan berkontraksi, sehingga feses menumpuk dan terjadi konstipasi kronis berat atau obstipasi yang tidak responsif terhadap terapi medis.

Ciri-ciri umum: Tidak ada atau berkurang atau sulit buang air besar dengan mengejan berulang tanpa hasil, feses kecil, keras, dan kering, serta nyeri saat buang air besar atau perut membengkak. Pada kasus kronis atau berat muncul penurunan nafsu makan, lesu, muntah, penurunan berat badan, dan dehidrasi, kadang disertai cairan feses atau darah dan lendir yang tampak seperti diare.

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; polanya adalah konstipasi yang berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, makin sering dan makin tidak responsif terhadap terapi medis, dengan kolon teraba membesar penuh feses keras dan tampak sangat melebar di radiograf, kadang disertai "diare semu" berupa cairan yang merembes melewati fekalit.

Tanda darurat: Tidak ada daftar darurat megakolon yang distandardisasi; yang memerlukan perhatian dokter hewan segera adalah mengejan yang tidak dapat dibedakan antara buang air besar dan buang air kecil (perlakukan sebagai darurat sampai terbukti sebaliknya), tidak dapat mengeluarkan apa pun disertai nyeri, serta muntah, lesu berat, kehilangan nafsu makan, nyeri abdomen nyata, atau dehidrasi yang menyertai obstipasi.

Penanganan inti: Penanganan medis dicoba dulu — rehidrasi, evakuasi kolon dengan enema dan pengeluaran feses manual di bawah sedasi atau anestesi, laksatif atau pelunak feses atas resep dokter hewan, dan prokinetik untuk merangsang motilitas yang tersisa; bila medis gagal, pembedahan subtotal kolektomi menjadi pilihan utama.

Pencegahan inti: Pencegahan megakolon idiopatik secara spesifik belum terverifikasi; yang dapat dilakukan adalah menangani konstipasi sejak dini dan jangan membiarkannya berulang tanpa evaluasi, menjaga hidrasi dan makanan basah, mengelola kotak pasir, serta mengoreksi penyebab sekunder sebelum retensi feses terjadi.

Peringatan penting: Jangan melakukan enema di rumah tanpa instruksi dokter hewan (enema fosfat yang dijual bebas disebut toksik untuk kucing).

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/ask-elizabeth-what-there-treat-idiopathic-megacolon); VCA Animal Hospitals

(https://vcahospitals.com/roberts/know-your-pet/megacolon-in-cats); MSD Veterinary Manual (https://www.msdvetmanual.com/digestive-system/surgical-problems-of-the-gastrointestinal-tract-in-small-animals/megacolon-in-cats)

Entri 35 — Penyakit radang usus (Inflammatory bowel disease / IBD)

Apa itu: Sindrom peradangan kronis saluran cerna — bukan satu penyakit tunggal — ketika sel-sel radang menginfiltrasi dan menebalkan dinding usus sehingga pencernaan dan penyerapan makanan terganggu.

Ciri-ciri umum: Gejala dominan yang berlangsung jangka panjang dan kadang kambuh-remisi adalah muntah kronis atau berulang, diare kronis, penurunan berat badan, perubahan nafsu makan, tinja berdarah, dan lesu. Muntah bola bulu lebih dari sekali sebulan bukan hal normal dan dapat menjadi tanda penyakit ini.

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; yang mengarahkan adalah gejala saluran cerna yang menetap atau berulang selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan (muntah kronis, diare, penurunan berat badan), dengan pola sesuai lokasi, dan respons terhadap uji makanan yang membedakan enteropati responsif makanan dari IBD; IBD dan limfoma usus berbagi gejala yang sama sehingga pembeda pastinya adalah histopatologi atau biopsi.

Tanda darurat: IBD sendiri bukan keadaan darurat akut; yang darurat adalah perburukan mendadak — muntah terus-menerus (terutama berdarah atau seperti ampas kopi), diare dengan banyak darah, tinja hitam seperti ter, perut sangat nyeri dan keras, gusi pucat, atau kelemahan dan tidak merespons (daftar ini dari Joii, bukan daftar resmi Cornell/VCA/Merck).

Penanganan inti: Cari dan hilangkan penyebab bila dapat diidentifikasi, lalu uji makanan hipoalergenik atau protein terhidrolisis secara eksklusif sebagai pilar utama; bila tidak cukup, kortikosteroid dan, bila gagal, imunosupresan yang lebih poten atas resep dokter hewan, dengan dukungan vitamin B12 bila terjadi malabsorpsi.

Pencegahan inti: Tidak ada metode pencegahan spesifik yang diketahui untuk IBD; yang dapat disampaikan hanyalah langkah kesehatan umum seperti diet seimbang berkualitas baik dan pemeriksaan dokter hewan teratur agar penyakit tertangkap lebih awal.

Peringatan penting: Jangan membiarkan kucing kelaparan karena menolak makanan uji, dan diet eliminasi rumahan hanya boleh diberikan selama waktu yang dianjurkan dokter hewan karena bisa tidak lengkap gizinya.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/inflammatory-bowel-disease); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/inflammatory-bowel-disease-in-cats); Merck Veterinary Manual (https://www.merckvetmanual.com/cat-owners/digestive-disorders-of-cats/disorders-of-the-stomach-and-intestines-in-cats?query=cat%20irritable%20bowel)

Entri 36 — Hiperadrenokortisisme (Sindrom Cushing)

Apa itu: Gangguan hormon akibat produksi kortisol yang konstan dan berlebihan dari kelenjar adrenal, sehingga berbagai sistem tubuh terpapar glukokortikoid berlebih dalam jangka panjang; penyakit ini jarang pada kucing dan sering berkaitan dengan diabetes yang sulit dikendalikan.

Ciri-ciri umum: Gejala sering tidak spesifik, ringan pada awalnya lalu memburuk, dan banyak tumpang tindih dengan diabetes yang tidak terkendali: minum dan buang air kecil berlebihan, nafsu makan meningkat, perut membuncit, lesu, pengurusan dan kelemahan otot, bulu buruk, rambut rontok, serta kulit tipis dan rapuh. Infeksi berulang (kulit, saluran kemih, saluran napas atas) juga dilaporkan.

Tanda khas: Kulit sangat tipis dan rapuh hingga mudah robek saat penanganan atau grooming biasa — disebut "essentially pathognomonic" oleh Cook & Evans — disertai alopesia simetris non-gatal, kegagalan rambut tumbuh kembali, dan diabetes yang sulit diatur; kerapuhan kulit juga dapat terjadi akibat glukokortikoid eksogen, sehingga bukan bukti mutlak tanpa tes endokrin.

Tanda darurat: Tidak ada klasifikasi darurat baku yang terverifikasi; bentuk yang cenderung berat adalah kulit rapuh ekstrem dengan robekan luas dan luka sulit sembuh yang berisiko sepsis, tumor adrenal ganas atau tumor hipofisis besar dengan gejala neurologis, serta diabetes bersamaan yang tidak terkendali dan infeksi bakteri berulang.

Penanganan inti: Tergantung bentuknya — bentuk iatrogenik ditangani dengan penghentian bertahap obat penyebab; trilostane adalah pilihan utama medis saat ini; dan pembedahan adrenalektomi dapat kuratif untuk tumor adrenal unilateral, dengan pemantauan laboratorium berkala selama terapi.

Pencegahan inti: Bentuk spontan (tumor hipofisis atau adrenal) tidak dapat dicegah dengan cara yang terverifikasi; yang dapat dikurangi risikonya hanyalah bentuk iatrogenik, yaitu menghindari kortikosteroid yang tidak perlu atau jangka

panjang, memakai dosis efektif terendah untuk durasi tersingkat atas arahan dokter hewan, dan menarik obat secara bertahap.

Peringatan penting: Jangan menghentikan kortikosteroid secara mendadak tanpa arahan dokter hewan (berisiko insufisiensi adrenal), dan tangani kucing dengan sangat lembut karena kulitnya mudah robek bahkan saat grooming biasa.

Sumber utama: International Cat Care (https://icatcare.org/articles/hyperadrenocorticism-cushings-disease); American Animal Hospital Association (https://www.aaha.org/resources/2023-aaha-selected-endocrinopathies-of-dogs-and-cats-guidelines/feline-hyperadrenocorticismhypercortisolism/); Cook & Evans, Journal of Feline Medicine and Surgery (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11163885/)

Entri 37 — Hipotiroidisme (Feline hypothyroidism)

Apa itu: Kondisi ketika kadar hormon tiroid (T4 dan T3) menurun sehingga laju metabolisme melambat; penyakit ini sangat jarang terjadi alami pada kucing dan sebagian besar bersifat iatrogenik setelah pengobatan hipertiroidisme, selain bentuk kongenital dan spontan dewasa yang langka.

Ciri-ciri umum: Pada kucing dewasa, gejala mencerminkan perlambatan metabolisme: lesu dan penurunan aktivitas, kenaikan berat badan meski nafsu makan menurun, bulu kusam, kering, rontok, dan tumbuh kembali dengan buruk, intoleransi dingin, denyut jantung lambat, dan konstipasi. Pada anak kucing bentuk kongenital menimbulkan pertumbuhan lambat dengan tubuh pendek, kepala lebar, dan tungkai pendek, disertai letargi berat dan konstipasi berat.

Tanda khas: Tidak ada gejala patognomonik; pembeda terkuat adalah riwayat pengobatan hipertiroidisme (tiroidektomi, radioiodin, atau obat antitiroid) diikuti pola "melambat" — berat naik, nafsu makan turun, lesu, denyut jantung lambat, suhu tubuh rendah — yang berlawanan dengan hipertiroidisme, serta dwarfisme disproporsional pada anak kucing untuk bentuk kongenital.

Tanda darurat: Tidak ada tanda darurat spesifik yang terverifikasi.

Penanganan inti: Terapi pengganti hormon tiroid dengan levothyroxine oral, umumnya seumur hidup untuk bentuk kongenital dan sebagian besar bentuk didapat, dengan pemeriksaan darah ulang untuk menyesuaikan terapi; bentuk akibat obat antitiroid berlebih biasanya membaik setelah dosis obat tersebut dikurangi atau disesuaikan dan tidak memerlukan terapi permanen.

Pencegahan inti: Tidak ada pencegahan yang terbukti untuk bentuk kongenital dan spontan; risiko bentuk iatrogenik dikurangi dengan memberi obat antitiroid tepat sesuai resep tanpa mengubah dosis sendiri, datang kontrol ulang sesuai jadwal, dan memantau T4 dan TSH setelah pengobatan kuratif.

Peringatan penting: Jangan mengubah dosis obat antitiroid sendiri.

Sumber utama: Merck Veterinary Manual (https://www.merckvetmanual.com/cat-owners/hormonal-disorders-of-cats/disorders-of-the-thyroid-gland-in-cats); PetMD (https://www.petmd.com/cat/conditions/endocrine/hypothyroidism-in-cats); American Animal Hospital Association (https://www.aaha.org/resources/2023-aaha-selected-endocrinopathies-of-dogs-and-cats-guidelines/feline-hypothyroidism/)

Entri 38 — Keracunan (Feline poisoning / toksikosis)

Apa itu: Kondisi akibat paparan zat toksik — tertelan, kontak kulit atau bulu lalu dijilat saat grooming, atau terhirup — yang merusak organ sasaran dan dapat mengancam nyawa; ini bukan satu penyakit dengan satu perjalanan klinis karena organ sasaran dan kecepatannya ditentukan agennya (lili merusak ginjal, parasetamol merusak darah dan hati, permetrin mengganggu saraf, antikoagulan menghambat pembekuan darah).

Ciri-ciri umum: Gejala umum lintas agen bersifat tidak spesifik dan tidak cukup membedakan agennya: muntah, diare, lesu, hilang nafsu makan, liur berlebihan, jalan sempoyongan, napas berat, darah dalam tinja atau urine, kejang, dan sulit bernapas. Riwayat paparan (tanaman, obat, produk kutu, atau racun tikus apa) adalah kunci untuk mengenali penyebabnya.

Tanda khas: Polanya berbeda per agen — lili: muntah lalu banyak minum dan buang air kecil, dan akhirnya tidak ada urine sama sekali; parasetamol: selaput lendir cokelat-lumpur disertai bengkak wajah atau kaki dan sesak dalam beberapa jam; permetrin: tremor, kedutan, dan hipersensitivitas setelah paparan produk kutu anjing; antikoagulan: tanpa gejala berhari-hari lalu perdarahan atau pucat muncul 3–7 hari kemudian.

Tanda darurat: Semua paparan yang dicurigai adalah darurat untuk konsultasi segera meski kucing tampak normal; segera ke dokter hewan bila ada kejang, tremor menyeluruh tak berhenti, sulit bernapas, gusi cokelat-lumpur, pucat, atau kebiruan, kolaps, muntah berulang, tidak ada urine, perdarahan, memar tak jelas, atau tinja berdarah atau hitam.

Penanganan inti: Hanya dokter hewan yang melakukan dekontaminasi dan pemberian antidotum — untuk lili: induksi muntah bila dini, arang aktif, dan cairan infus untuk melindungi ginjal (tidak ada antidotum spesifik); untuk parasetamol: dekontaminasi dini dan pengobatan methemoglobinemia serta kerusakan hati; untuk permetrin: pengendalian kejang dulu baru pemandian setelah stabil.

Pencegahan inti: Jangan membawa lili ke rumah berkucing; jangan pernah memberi obat manusia tanpa konsultasi dokter hewan dan simpan obat terkunci; jangan pernah memakai produk kutu anjing pada kucing dan pisahkan kucing dari anjing yang diobati permetrin (Cornell 24 jam, ICC 72 jam — ikuti label produk); gunakan stasiun umpan pelindung untuk rodentisida dan simpan antibeku atau bahan kimia tertutup di luar jangkauan.

Peringatan penting: JANGAN memuntahkan kucing di rumah — hanya bila diarahkan secara spesifik oleh dokter hewan — karena dapat merusak kerongkongan atau lambung dan arang aktif berisiko teraspirasi; jangan memandikan kucing yang sedang kejang atau tremor berat di rumah tanpa arahan.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/common-cat-hazards); UC Davis School of Veterinary Medicine (https://healthtopics.vetmed.ucdavis.edu/health-topics/feline/lily-toxicity-cats?ref=musiclearningtribe.com); Merck Veterinary Manual (https://www.merckvetmanual.com/toxicology/toxicoses-from-human-analgesics/toxicoses-from-human-analgesics-in-animals)

Entri 39 — Ulkus kornea (Feline corneal ulcer / keratitis ulseratif)

Apa itu: Luka atau erosi pada permukaan kornea mata — dari abrasi superfisial hanya di epitel hingga ulkus dalam, desmetocele, dan perforasi — yang membuat kornea keruh dan, bila memburuk, dapat menyebabkan kebutaan bahkan kehilangan mata.

Ciri-ciri umum: Ulkus kornea sangat nyeri, dengan tanda menyipit atau menutup kelopak rapat-rapat, berkedip cepat, menghindari cahaya terang, menggosok mata, mata berair berlebihan, dan leleran mata yang bervariasi dari keputihan hingga hijau. Kornea tampak keruh atau berkabut, disertai kemerahan dan pembengkakan jaringan di sekitar mata.

Tanda khas: Tidak ada gejala awam yang sendirian membuktikan ulkus (konfirmasi memerlukan pewarnaan fluorescein); yang mengarahkan kuat adalah nyeri mata berat yang dominan (menyipit hebat, menggosok mata, fotofobia) disertai kornea keruh atau edema fokal dan neovaskularisasi, sedangkan ulkus dendritik

linear atau bercabang dianggap patognomonik untuk infeksi FHV-1.

Tanda darurat: Desmetocele (hanya membran Descemet tersisa) dan perforasi atau kebocoran cairan mata adalah darurat oftalmologi; begitu pula ulkus melting yang progresif cepat, ulkus dalam lebih dari 50%, ulkus yang memburuk meski sudah diobati, serta tanda infeksi berat seperti nanah atau darah di bilik depan mata.

Penanganan inti: Atasi penyebab yang mendasari, beri antimikroba topikal yang sesuai (profilaksis bila tidak terinfeksi, intensif bila infeksi aktif), kendalikan nyeri, dan dukung penyembuhan; ulkus herpes ditangani dengan antivirus (famciclovir oral atau cidofovir topikal) yang dilanjutkan 1–2 minggu setelah penyakit teratasi, dengan kontrol ulang dan fluorescein berulang.

Pencegahan inti: Tidak ada satu vaksin atau tindakan tunggal; gabungan pencegahan trauma, koreksi penyebab predisposisi (entropion, mata kering), vaksinasi FHV-1 untuk mengurangi keparahan ulkus herpes, pengurangan stres pemicu reaktivasi, serta higiene dan isolasi kucing bergejala di rumah multi-kucing.

Peringatan penting: Kortikosteroid topikal dilarang pada ulkus kornea — bila mata kembali nyeri setelah steroid dimulai, segera hentikan steroid dan periksakan kembali; kortikosteroid juga dapat memicu reaktivasi FHV-1.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/corneal-ulcers); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/corneal-ulcers-in-cats); Today's Veterinary Practice (https://todaysveterinarypractice.com/ophthalmology/feline-corneal-ulcers-diagnosis-and-management/)

Entri 40 — Kejang / epilepsi (Feline seizures / epilepsy)

Apa itu: Kejang adalah tanda, bukan penyakit itu sendiri — manifestasi lonjakan aktivitas listrik otak yang tiba-tiba dan tidak terkendali — sedangkan epilepsi adalah gangguan otak dengan kejang berulang yang tidak diprovokasi; epilepsi idiopatik jauh lebih jarang pada kucing daripada anjing sehingga penyebab struktural atau reaktif harus dicari.

Ciri-ciri umum: Sebelum kejang dapat muncul gelisah, cemas, mondar-mandir, dan liur berlebihan, lalu saat kejang umum kucing kolaps mendadak, hilang kesadaran, jatuh ke samping dengan tungkai kaku bergantian menyentak,

gerakan mengunyah, liur berlebihan, pupil melebar, dan buang air tanpa kendali. Setelah kejang muncul disorientasi, sempoyongan, letargi, tidur dalam, atau ketakutan ekstrem, sedangkan di antara kejang kucing dengan epilepsi idiopatik biasanya sepenuhnya normal.

Tanda khas: Kejang fokal mendominasi pada kucing dan mudah terlewat — kedutan otot wajah satu sisi, automatisme orofasial seperti mengecap bibir dan mengunyah, hipersalivasi, serta "running fits" berupa lari liar dan menabrak benda; kejang fokal dapat berkembang menjadi kejang umum, kadang begitu cepat sehingga komponen fokal awal terlewat.

Tanda darurat: Status epileptikus — kejang tunggal lebih dari 5 menit atau dua kejang atau lebih tanpa pulih penuh di antaranya — adalah emergensi yang mengancam jiwa; begitu pula kejang beruntun (lebih dari satu kejang dalam 24 jam), kejang pertama, kucing yang tidak sadar kembali, atau sulit bernapas.

Penanganan inti: Pertolongan pertama di rumah adalah melindungi kucing dari cedera tanpa menahannya, mencatat waktu dan merekam video bila aman; di klinik, kejang dihentikan secepat mungkin dengan benzodiazepin diikuti obat antikejang kerja panjang (fenobarbital atau levetirasetam), lalu penyebab yang mendasari dicari dan ditangani, dan terapi pemeliharaan dimulai bila memenuhi indikasi.

Pencegahan inti: Tidak ada pencegahan spesifik untuk epilepsi idiopatik; yang terverifikasi adalah mencegah penyebab yang didapat — hindari racun (termasuk produk permetrin anjing), cegah trauma kepala, pastikan diet lengkap dengan tiamin cukup, kelola penyakit penyerta sejak dini, dan pada kucing yang sudah epilepsi, berikan obat tepat waktu serta kenali pemicu individual.

Peringatan penting: Jangan menahan atau menindih tubuh kucing saat kejang, jangan memasukkan tangan atau benda apa pun ke dalam mulutnya, dan jangan memberi makan, minum, atau obat lewat mulut selama kejang; kalium bromida dan diazepam sebagai terapi pemeliharaan tidak dianjurkan untuk kucing.

Sumber utama: International Cat Care (http://icatcare.org/articles/seizures-in-cats); Hazenfratz & Taylor, Journal of Feline Medicine and Surgery (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10816265/); Today's Veterinary Practice (https://todaysveterinarypractice.com/neurology/feline-seizure-diagnosis-and-management/)

Entri 41 — Osteoartritis (Feline osteoarthritis)

Apa itu: Penyakit sendi degeneratif kronis dan progresif pada kucing, umumnya bilateral, yang tidak dapat disembuhkan tetapi nyerinya dapat dikelola.

Ciri-ciri umum: Gejala muncul bertahap selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan dan sering disangka penuaan normal, berupa enggan atau ragu melompat (melompat lebih jarang dan tidak setinggi dulu), kaku terutama setelah tidur atau istirahat, kurang bermain dan lebih banyak tidur, grooming berkurang hingga bulu kusut, serta lebih mudah marah atau lebih banyak menyendiri. Pincang bisa terjadi, tetapi pada kucing bukan gejala utama.

Tanda khas: Kucing jarang pincang jelas seperti anjing; yang menonjol adalah perubahan perilaku halus dan bertahap — ragu atau kurang melompat, kurang bermain, kurang grooming, lebih banyak tidur atau menyendiri, dan mudah marah saat disentuh — yang sering disangka sekadar penuaan.

Tanda darurat: Tidak ada tanda darurat spesifik yang terverifikasi. Namun ketidakmampuan berjalan mendadak, atau sendi panas dan sangat bengkak disertai demam, perlu segera diperiksa karena kemungkinan bukan sekadar osteoartritis.

Penanganan inti: Pendekatan multimodal atas resep dokter hewan: pereda nyeri, kontrol berat badan dan diet, modifikasi lingkungan (ramp atau tangga, bak pasir berdinding rendah, tempat tidur empuk yang mudah dijangkau), serta pemantauan berkala; operasi hanya untuk kasus ekstrem tertentu.

Pencegahan inti: Tidak ada pencegahan yang terbukti menjamin bebas osteoartritis; yang terverifikasi adalah menjaga kondisi tubuh ramping seumur hidup, nutrisi tepat sejak masa pertumbuhan, olahraga teratur yang sesuai, mencegah dan menangani cedera sendi sedini mungkin, serta deteksi dini lewat observasi perilaku dan pemeriksaan senior berkala.

Peringatan penting: Jangan pernah memberi obat manusia seperti ibuprofen, parasetamol (asetaminofen), atau aspirin — banyak yang bisa mematikan bagi kucing; NSAID dan kortikosteroid tidak boleh dipakai bersamaan.

Sumber utama: VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/arthritis-in-cats); International Cat Care (https://icatcare.org/articles/arthritis-in-cats); NC State University College of Veterinary Medicine (https://cvm.ncsu.edu/comparative-pain-research-and-education-center/arthritis-pain-in-cats/)

Entri 42 — Disfungsi kognitif (Feline cognitive dysfunction

syndrome)

Apa itu: Gangguan neurodegeneratif progresif terkait usia pada kucing senior yang ditandai penurunan belajar, memori, perhatian, dan kemampuan spasial, dan merupakan diagnosis eksklusi setelah penyakit medis lain disingkirkan.

Ciri-ciri umum: Tanda mulai jelas terlihat pada kucing berusia 10 tahun ke atas, berupa disorientasi, menatap kosong ke ruang atau dinding dalam waktu lama, perubahan siklus tidur-bangun, kurang minat bermain, buang air di luar litter box, serta episode vokalisasi keras yang tampaknya tanpa pemicu, sering tengah malam. Gejala lain yang sejalan adalah grooming berkurang hingga bulu kusut, perubahan interaksi dengan pemilik atau hewan lain, dan lupa perintah atau latihan litter box.

Tanda khas: Tidak ada satu gejala yang patognomonik; yang mengarahkan adalah pola gabungan yang bertahap pada kucing senior — disorientasi, perubahan interaksi, gangguan siklus tidur-bangun (terutama bersuara di malam hari), buang air di luar litter box, perubahan aktivitas, kecemasan, serta penurunan belajar dan memori (akronim VISHDAAL).

Tanda darurat: Tidak ada tanda darurat spesifik yang terverifikasi. Namun perubahan perilaku yang mendadak (bukan bertahap), kebutaan mendadak, kejang, kolaps, atau tidak makan dan minum sama sekali memerlukan evaluasi dokter hewan segera karena kemungkinan besar bukan disfungsi kognitif murni.

Penanganan inti: Tidak ada obat penyembuh; obati dulu penyakit penyerta (nyeri, hipertensi, hipertiroidisme, penyakit ginjal), lalu manajemen menyeluruh berupa pengayaan lingkungan dan rutinitas yang konsisten, akses mudah ke semua sumber daya, lampu malam, serta obat atas resep dokter hewan bila diperlukan (selegiline pada kucing bersifat off-label).

Pencegahan inti: Tidak ada pencegahan yang terbukti mencegah disfungsi kognitif sepenuhnya; yang mungkin menunda onset adalah stimulasi mental dan fisik berkelanjutan, diet kaya antioksidan dan omega-3, pemeriksaan senior rutin dan deteksi dini, serta pengelolaan nyeri dan penyakit penyerta sejak dini. Tidak ada vaksin untuk kondisi ini.

Peringatan penting: SSRI tidak boleh dipakai bersama selegiline, dan obat antikolinergik sebaiknya dihindari pada kucing senior bila memungkinkan.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/cognitive-dysfunction)

; International Cat Care (https://icatcare.org/articles/cognitive-dysfunction-syndrome-in-cats); American Animal Hospital Association (AAHA) (https://www.aaha.org/trends-magazine/publications/a-compassionate-approach-to-feline-cognitive-dysfunction/)

Entri 43 — Hipertensi sistemik (Feline systemic hypertension)

Apa itu: Tekanan darah arteri yang meninggi secara persisten, pada kucing paling sering sekunder akibat penyakit ginjal kronis atau hipertiroidisme, dan dapat merusak mata, otak, jantung, dan ginjal.

Ciri-ciri umum: Pada sebagian besar kucing tidak ada gejala sampai penyakitnya lanjut dan menimbulkan masalah mata yang berujung kebutaan mendadak, sehingga hipertensi sering bersifat "silent" dan kerusakan organ terjadi dalam jangka panjang sebelum pemilik menyadarinya. Bila ada gejala, umumnya berupa gejala penyakit yang mendasari atau kerusakan organ target, seperti lesu dan menarik diri, perubahan nafsu makan, pupil melebar menetap, menabrak furnitur, disorientasi atau berjalan sempoyongan, murmur jantung, serta minum dan buang air kecil yang meningkat.

Tanda khas: Tidak ada satu gejala yang patognomonik; yang paling mengarahkan adalah kebutaan mendadak dengan pupil melebar menetap dan/atau perdarahan atau lepasnya retina, gejala neurologis akut saat tekanan sangat tinggi, bukti kerusakan multi-organ bersamaan, serta tekanan sistolik yang menetap tinggi pada pengukuran ulang yang benar.

Tanda darurat: Kebutaan mendadak, darah terlihat di mata, kejang, kolaps, penurunan kesadaran, disorientasi berat mendadak, sesak napas berat, atau mimisan yang tidak berhenti — keadaan ini termasuk "hypertensive emergency" menurut ACVIM dan memerlukan penilaian di hari yang sama; tekanan sistolik ≥180 mmHg tanpa gejala pun perlu konfirmasi dalam 1–2 minggu.

Penanganan inti: Turunkan tekanan darah secara bertahap (bukan mendadak) dan umumnya seumur hidup; amlodipin adalah lini pertama pada kucing, ditambah telmisartan atau benazepril terutama bila ada proteinuria, disertai pengobatan penyakit dasarnya dan pemantauan tekanan darah berkala.

Pencegahan inti: Tidak ada pencegahan primer spesifik yang terverifikasi; bentuk pencegahan terkuat adalah skrining tekanan darah teratur pada kucing berisiko (umumnya mulai usia 7–9 tahun atau bila ada penyakit ginjal kronis atau hipertiroidisme), deteksi dan pengobatan dini penyakit dasar, pengukuran yang benar untuk menghindari diagnosis palsu, serta

kepatuhan pengobatan dan kontrol berkala.

Peringatan penting: Jangan menghentikan obat antihipertensi mendadak tanpa arahan dokter hewan; jangan memakai alat pengukur tekanan darah rumahan yang belum tervalidasi sebagai pengganti pengukuran klinik.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/hypertension); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/systemic-hypertension-in-cats); ACVIM Consensus Statement 2018 (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6271319/)

Entri 44 — Penyakit cacing jantung (Feline heartworm disease)

Apa itu: Infeksi parasit Dirofilaria immitis yang ditularkan nyamuk dan terutama menyerang paru dan pembuluh paru kucing; kucing adalah inang atipikal dengan beban cacing hanya 1–6 ekor, namun reaksi imun paru terhadap cacing yang mati (sindrom HARD) dapat berat.

Ciri-ciri umum: Tidak ada gejala yang spesifik untuk penyakit ini, dan kucing terinfeksi dapat tidak menunjukkan tanda atau hanya tanda ringan. Gejala yang paling sering dilaporkan adalah batuk, napas cepat, sesak napas, mengi atau serangan mirip asma, muntah berkala, nafsu makan menurun, penurunan berat badan, lesu dan intoleransi olahraga, sementara sebagian kucing tanpa gejala sama sekali hingga kematian mendadak menjadi tanda pertama.

Tanda khas: Tidak ada satu gejala yang patognomonik; yang mengarahkan adalah serangan napas mirip asma pada dua titik kritis (saat cacing muda tiba dan mati di arteri paru, serta saat cacing dewasa mati), kombinasi batuk atau sesak dengan muntah kronis dan penurunan berat badan, serta onset mendadak yang dramatis (kolaps, sesak akut, kejang, kebutaan, atau kematian mendadak) pada kucing yang sebelumnya tampak sehat.

Tanda darurat: Kolaps atau pingsan, sesak berat, kejang, kebutaan mendadak, denyut jantung cepat, dan syok — kasus hiperakut memerlukan stabilisasi ICU karena risiko gagal napas dan syok.

Penanganan inti: Suportif dan berorientasi gejala plus pemantauan, bukan membunuh cacing dewasa secepatnya: pemantauan berkala pada kucing tanpa gejala, kortikosteroid untuk gejala pernapasan, dukungan oksigen dan perawatan krisis bila perlu, pembatasan aktivitas, dan melanjutkan preventif bulanan untuk mencegah infeksi baru; bedah hanya untuk kasus berat terpilih

dengan risiko kematian tinggi.

Pencegahan inti: Kemoprofilaksis makrosiklik lakton bulanan sepanjang tahun di daerah endemis (mulai sesuai label produk, umumnya 6 minggu–2 bulan), tes sebelum memulai profilaksis, pengendalian nyamuk lingkungan sebagai pelengkap, dan ingat bahwa tinggal di dalam rumah saja tidak cukup karena nyamuk dapat masuk rumah; tidak ada vaksin.

Peringatan penting: Tidak ada obat adultisida yang disetujui atau aman untuk kucing; melarsomine (obat anjing) dianggap toksik bagi kucing dan tidak boleh dipakai — jangan pernah memberikan produk cacing jantung anjing ke kucing tanpa arahan dokter hewan.

Sumber utama: European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-feline-heartworm-disease/); American Heartworm Society (https://www.heartwormsociety.org/pet-owner-resources/heartworm-in-cats?highlight=WyJza2luIiwib2YiLCJza2luIG9mIl0%3D); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/heartworm)

Entri 45 — Cacing paru (Feline lungworm disease)

Apa itu: Infeksi cacing nematoda di saluran napas dan paru kucing, terutama Aelurostrongylus abstrusus, dengan Troglostrongylus brevior yang lebih berbahaya pada anak kucing dan Eucoleus aerophilus yang bersiklus langsung dan berpotensi zoonotik.

Ciri-ciri umum: Banyak kucing tidak menunjukkan gejala dan infeksi ditemukan secara insidental, dengan gejala yang bergantung pada jumlah parasit, status imun, dan lokasi infeksi. Yang dilaporkan adalah batuk sebagai gejala paling sering (berupa batuk produktif pada aelurostrongylosis), napas cepat, sesak napas dan napas berbunyi, bersin serta leler hidung atau mata, lesu, nafsu makan menurun, penurunan berat badan, dan demam yang jarang pada A. abstrusus.

Tanda khas: Tidak ada satu gejala pun yang patognomonik; yang mengarahkan adalah kombinasi riwayat paparan (kucing muda, outdoor, suka berburu, di daerah endemis) dengan batuk produktif dan leler hidung mukopurulen yang menetap dan tidak membaik dengan terapi asma semata, serta gagal napas berat pada anak kucing yang mengarahkan ke T. brevior.

Tanda darurat: Sesak napas berat atau gagal napas, napas dengan mulut terbuka, napas perut yang berat, sianosis, pneumotoraks akut, efusi pleura yang memerlukan torakosentesis, serta hipertensi pulmonal berat dan gagal

jantung kanan — terutama pada anak kucing — yang dapat fatal.

Penanganan inti: Antiparasit atas resep dokter hewan (regimen berbeda menurut spesies, wilayah, dan lisensi, sehingga tidak ada satu regimen tunggal yang benar), ditambah perawatan pendukung berupa antibiotik dan kortikosteroid bila ada komplikasi, terapi oksigen dan rawat inap pada sesak berat, serta pemeriksaan feses pasca-pengobatan untuk memastikan larva berhenti keluar.

Pencegahan inti: Menghindari predasi adalah satu-satunya tindakan pencegahan yang tercantum dalam panduan ABCD 2015, ditambah produk spot-on berlisensi untuk pencegahan (tiap bulan sepanjang tahun di daerah sangat endemis untuk kucing outdoor atau pemburu), membatasi akses luar, dan pemeriksaan feses berkala; tidak ada vaksin.

Peringatan penting: Tanda napas dapat muncul atau memburuk setelah pengobatan karena kematian parasit memicu peradangan, terutama pada kasus berat dan anak kucing dengan troglostrongylosis — karena itu kucing yang diobati harus dipelihara di dalam rumah dan dipantau; antibiotik saja tidak membunuh cacing.

Sumber utama: European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-lungworm-disease/); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/lungworm-infections-in-cats); ESCCAP (https://www.esccap.org/uploads/docs/8ra0787s_0778_ESCCAP_GL1__Worm_Management_Scheme_Fact_Sheet__Cats_v8.pdf)

Entri 46 — Bartonellosis (Infeksi Bartonella henselae)

Apa itu: Infeksi bakteri Bartonella henselae yang ditularkan kutu kucing (Ctenocephalides felis); sebagian besar kucing terinfeksi tampak sehat dan mengalami bakteremia tanpa gejala selama berbulan-bulan, namun tetap menjadi reservoir bagi manusia.

Ciri-ciri umum: Yang dominan pada kucing adalah tidak ada gejala, karena sebagian besar kucing yang terinfeksi alami tidak menunjukkan tanda klinis, atau hanya mengalami penyakit demam singkat yang sembuh sendiri selama 2–3 hari. Bila kucing sakit, gejala yang dilaporkan (jarang, dan hubungan sebab-akibatnya sering belum terbukti tegas) adalah demam, lesu, nafsu makan menurun, muntah, mata merah, dan pembengkakan kelenjar getah bening.

Tanda khas: Tidak ada gejala khas yang patognomonik pada kucing; diagnosis ditegakkan

berdasarkan eksklusi penyakit lain dan respons terhadap terapi antibiotik, dengan pola yang paling membantu berupa kucing tampak sehat meski bakteremik disertai riwayat infestasi kutu yang jelas, serta bentuk kardiak atau okular yang jarang (endokarditis, miokarditis, uveitis).

Tanda darurat: Tidak ada tanda darurat spesifik yang terverifikasi. Pemicu pemeriksaan menurut CDC adalah demam lebih dari 3 hari, muntah, letargi, mata merah, kelenjar getah bening bengkak, atau nafsu makan menurun; tanda kardiak seperti murmur, kelemahan tungkai belakang, dan nyeri panggul juga mengkhawatirkan.

Penanganan inti: Antibiotik tidak dianjurkan untuk kucing sehat pembawa; antibiotik hanya untuk kucing yang benar-benar sakit karena Bartonella atau yang tinggal bersama orang dengan gangguan imun, berupa antibiotik kombinasi atas keputusan dokter hewan selama berminggu-minggu, ditambah perawatan suportif intensif pada bentuk kardiak dan pengendalian kutu yang tetap berjalan.

Pencegahan inti: Pengendalian kutu (dan caplak) yang ketat adalah satu-satunya tindakan pencegahan yang efektif; tidak ada vaksin; pelihara kucing di dalam rumah, obati semua hewan serumah, dan kurangi risiko zoonosis dengan menghindari permainan kasar, memotong kuku, serta segera mencuci luka dengan sabun dan air.

Peringatan penting: Jangan memberi antibiotik empiris atau profilaksis pada kucing sehat karena pembersihan total tidak dapat dijamin dan berisiko resistansi; jangan pernah memakai produk permetrin pada kucing.

Sumber utama: European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-feline-bartonellosis/); Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (https://www.cdc.gov/bartonella/hcp/veterinary-guidance/index.html); VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/pediatric/kitten/health-wellness/cat-scratch-fever)

Entri 47 — Kriptokokosis (Feline cryptococcosis)

Apa itu: Infeksi jamur sistemik paling umum pada kucing, disebabkan kompleks spesies Cryptococcus neoformans–Cryptococcus gattii yang dihirup dari lingkungan (kotoran burung, terutama merpati, dan vegetasi membusuk), dengan bentuk hidung sebagai yang paling umum.

Ciri-ciri umum: Gejala bergantung pada bentuk atau organ yang terlibat dan perjalanan penyakit umumnya kronis dan progresif, dengan bentuk hidung sebagai yang

paling umum: leleran hidung kronis satu atau dua sisi, bersin, suara napas mendengkur atau keras, napas inspirasi sulit, pembengkakan hidung dan wajah, serta nafsu makan menurun dan berat badan turun. Bentuk lain meliputi nodul kulit yang tidak gatal dan tidak nyeri, kebutaan mendadak, kejang dan perubahan perilaku pada bentuk sistem saraf pusat, serta letargi dan kurus parah pada penyakit diseminata kronis.

Tanda khas: Tidak ada satu gejala pun yang patognomonik; kombinasi yang sangat sugestif adalah pembengkakan batang hidung atau wajah yang tegas dan tidak nyeri ("clown nose"), ulkus hidung dalam yang tidak sembuh dan mengeluarkan eksudat gelatinosa, leleran hidung kronis, nodul kulit tidak nyeri, serta penyebaran ke mata dan sistem saraf pusat setelah riwayat penyakit hidung kronis.

Tanda darurat: Tidak ada tanda darurat spesifik yang terverifikasi. Penyakit ini umumnya bukan kegawatdaruratan dalam hitungan menit, tetapi sesak napas berat atau bernapas lewat mulut, kejang, kebutaan mendadak, perubahan perilaku atau kesadaran yang cepat, dan kelemahan berat adalah manifestasi bentuk berat yang memerlukan penilaian dokter hewan segera.

Penanganan inti: Antijamur oral berbulan-bulan hingga sekitar setahun, dipantau dengan titer antigen (LCAT) hingga negatif: flukonazol sebagai lini pertama untuk bentuk ringan–terlokalisir, amfoterisin B dikombinasikan dengan flusitosin atau flukonazol untuk bentuk sistem saraf pusat, mata, dan sistemik, ditambah eksisi bedah nodul atau massa sebagai terapi tambahan dan stabilisasi oksigen pada dispnea berat.

Pencegahan inti: Tidak ada vaksin dan belum terbukti ada langkah pencegahan yang efektif; memelihara kucing di dalam rumah dan menghindari guano merpati serta vegetasi membusuk hanya dapat mengurangi paparan, bukan menghilangkan risiko, dan kucing indoor pun dapat terdiagnosis.

Peringatan penting: Kondisi kucing dengan kriptokokosis serebral dapat memburuk segera setelah memulai amfoterisin B; amfoterisin B bersifat nefrotoksik dan flukonazol maupun itrakonazol bersifat teratogenik — semua pengobatan harus di bawah pengawasan dokter hewan.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/cryptococcosis); European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) (https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-cryptococcosis-in-cats/); PetMD (https://www.petmd.com/cat/conditions/infectious-parasitic/cryptococcosis-in

-cats)

Entri 48 — Kolangitis (Feline cholangitis)

Apa itu: Radang saluran empedu kucing (bila meluas ke jaringan hati disebut kolangiohepatitis), dengan dua bentuk utama: neutrofilik (supuratif, akut, biasanya bakteri dari usus yang naik lewat saluran empedu) dan limfositik (non-supuratif, kronis, diduga imun-mediated), yang sering menyertai pankreatitis dan penyakit radang usus (triaditis).

Ciri-ciri umum: Gejala sering samar dan non-spesifik, dengan yang paling umum dilaporkan adalah muntah, penurunan berat badan, hilang atau berkurangnya nafsu makan, ikterus atau kuning pada kulit, gusi dan mata, serta demam. Gejala lain meliputi lesu, dehidrasi, nyeri perut dan hati membesar, sementara sebagian kucing didiagnosis sebelum muncul gejala klinis, misalnya dari perubahan darah rutin.

Tanda khas: Tidak ada satu gejala yang patognomonik; pola yang membantu adalah onset akut dengan demam, letargi, dan nyeri perut pada bentuk neutrofilik, berbanding perjalanan kronis, lambat, dan episodik (penurunan berat badan perlahan, muntah intermiten, ikterus yang sembuh sendiri) pada bentuk limfositik, sedangkan ikterus persisten dengan tinja pucat mengarah pada bentuk destruktif.

Tanda darurat: Tidak ada tanda darurat spesifik yang terverifikasi. Yang terverifikasi sebagai alasan segera ke dokter hewan adalah kucing berhenti makan lebih dari beberapa hari (risiko lipidosis hepatik) dan penyakit neutrofilik berat yang memerlukan rawat inap; kolaps, nyeri hebat, atau perburukan cepat adalah anjuran kehati-hatian umum, bukan kriteria terverifikasi.

Penanganan inti: Perawatan suportif untuk semua bentuk (cairan intravena, anti-mual, pereda nyeri, dan dukungan nutrisi — termasuk selang makanan bila perlu), antibiotik spektrum luas yang disesuaikan kultur untuk bentuk neutrofilik (durasi menurut sumber: Cornell 4–6 minggu berbanding Merck 8–12 minggu), imunosupresi jangka panjang untuk bentuk limfositik, asam ursodeoksikolat bila sesuai, dan operasi bila ada obstruksi saluran empedu.

Pencegahan inti: Pencegahan spesifik yang terbukti untuk kolangitis neutrofilik atau limfositik belum terverifikasi; yang dapat dilakukan adalah deteksi dan pengobatan dini sebelum kerusakan hati signifikan, tidak membiarkan kucing berhenti makan, mengelola penyakit penyerta (penyakit radang usus dan pankreatitis), serta pemantauan jangka panjang untuk mencegah kekambuhan. Tidak ada vaksin.

Peringatan penting: Asam ursodeoksikolat tidak lagi direkomendasikan pada kolangitis destruktif; overdosis vitamin K1 dapat menyebabkan anemia hemolitik serius dan overdosis vitamin E dapat mengurangi aktivitas vitamin K.

Sumber utama: Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/cholangiohepatitis); Merck Veterinary Manual (https://www.merckvetmanual.com/digestive-system/hepatic-diseases-of-small-animals/feline-cholangitis-cholangiohepatitis-syndrome?mredirectid=1157); International Cat Care (https://icatcare.org/articles/liver-and-gall-bladder-disease-in-cats)

Entri 49 — Akromegali (Hipersomatotropisme)

Apa itu: Sindrom akibat kelebihan hormon pertumbuhan kronis pada kucing dewasa, hampir selalu dari tumor hipofisis anterior yang mensekresi GH, yang menimbulkan resistensi insulin (diabetes melitus yang sulit dikendalikan) sekaligus pertumbuhan tulang, kartilago, otot, dan organ dalam melalui IGF-1.

Ciri-ciri umum: Gejala yang paling sering pertama kali membawa kucing ke dokter hewan adalah gejala diabetes melitus yang tidak terkendali, yaitu buang air kecil berlebihan, minum berlebihan, nafsu makan meningkat yang sering digambarkan ekstrem, dan penambahan berat badan. Disertai perubahan fisik bertahap seperti wajah melebar, rahang bawah memanjang atau menonjol, telapak kaki membesar dan ukuran tubuh membesar, pembesaran organ dalam, serta bunyi napas kasar saat inspirasi akibat penebalan jaringan lunak.

Tanda khas: Tidak ada satu gejala yang patognomonik; kombinasi yang paling membedakan adalah diabetes melitus yang resisten insulin ditambah penambahan berat badan (bukan penurunan) di tengah diabetes yang tidak terkendali, wajah melebar, rahang bawah menonjol, telapak kaki membesar, stridor pernapasan, dan kebutuhan insulin yang sangat tinggi dan terus meningkat — namun tidak adanya gambaran klasik tidak menyingkirkan diagnosis ini.

Tanda darurat: Tidak ada tanda darurat spesifik yang terverifikasi. Komplikasi serius yang memerlukan evaluasi dokter hewan segera adalah napas mulut terbuka atau sesak saat stres (gagal jantung kongestif), stridor berat atau obstruksi jalan napas atas, tanda neurologis (berjalan berputar, kejang, kebutaan), serta hipoglikemia yang mengancam jiwa akibat insulin dosis tinggi, terutama pasca-radioterapi.

Penanganan inti: Insulin untuk diabetesnya, terapi definitif terhadap tumor di pusat spesialis

(radioterapi yang manfaatnya tidak instan, atau hipofisektomi transsfenoidal yang dapat kuratif tetapi sangat spesialis), dan obat-obatan seperti analog somatostatin pada sebagian kucing dengan bukti dan ketersediaan terbatas; perawatan penyakit penyerta (gagal jantung, penyakit ginjal) menyertainya.

Pencegahan inti: Tidak ada pencegahan spesifik yang terverifikasi karena penyebab awal adenoma tidak diketahui; yang boleh ditulis adalah perawatan veteriner rutin agar gejala tertangkap awal dan pemantauan kucing diabetes yang tidak merespons pengobatan standar dalam 4 bulan untuk skrining IGF-1.

Peringatan penting: Hipoglikemia yang mengancam jiwa dapat terjadi tiba-tiba pada insulin dosis tinggi karena sekresi GH tetap pulsatil, terutama pasca-radioterapi ketika sensitivitas insulin kembali — pemantauan glukosa darah di rumah sebelum tiap dosis insulin dan komunikasi erat dengan dokter hewan menjadi esensial; ketoasidosis diabetik justru jarang pada akromegali menurut Merck, jadi jangan ditulis sebagai komplikasi yang khas.

Sumber utama: Merck Veterinary Manual (https://www.merckvetmanual.com/endocrine-system/the-pituitary-gland/acromegaly-in-cats?autoredirectid=25239&ruleredirectid=477); Michigan State University College of Veterinary Medicine (https://cvm.msu.edu/vdl/laboratory-sections/endocrinology/growth-hormone-and-igf-1-in-cats); Niessen, Journal of Feline Medicine and Surgery 2010 (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10845472/)

Entri 50 — Infeksi telinga luar (Otitis eksterna)

Apa itu: Radang saluran telinga luar kucing yang dapat disebabkan tungau telinga, infeksi bakteri dan ragi sekunder, alergi, benda asing, polip, atau tumor — otitis eksterna adalah lokasi dan proses peradangannya, sedangkan tungau hanyalah salah satu penyebabnya.

Ciri-ciri umum: Gejala yang konsisten adalah menggeleng-gelengkan kepala berulang, menggaruk atau menggosok telinga dan kepala, telinga merah, bengkak, hangat dan nyeri bila disentuh, sekret telinga abnormal yang meningkat (hitam, cokelat, kuning atau keputihan) dan berbau tidak sedap, serta kulit bersisik atau berkerak di daun telinga. Perubahan perilaku berupa gelisah, lesu dan bersembunyi juga dilaporkan, dan pada kasus lebih lanjut telinga terkulai atau miring ke satu sisi serta daun telinga bengkak berisi darah (hematoma aural) akibat garukan keras.

Tanda khas: Tidak ada satu gejala pun yang patognomonik; gejala tumpang tindih dengan

infestasi tungau dan penyakit telinga tengah atau dalam, sehingga yang membantu hanyalah pola ditambah pemeriksaan: sekret kering seperti ampas kopi dan gatal hebat mengarah ke tungau, sekret berminyak berbau ragi mengarah ke Malassezia, sekret kuning kental berbau menyengat mengarah ke bakteri gram-negatif, dan gejala satu sisi kronis yang tidak membaik mengarah ke polip — semuanya tetap memerlukan otoskopi dan sitologi.

Tanda darurat: Kepala miring menetap, kehilangan keseimbangan, berjalan memutar, nistagmus, muntah, wajah terkulai satu sisi, sindrom Horner, penurunan pendengaran mendadak terutama setelah obat tetes, nyeri hebat, hematoma daun telinga mendadak, atau kejang dan penurunan kesadaran — tanda-tanda ini menunjukkan penyakit sudah melewati telinga luar atau komplikasi berat dan memerlukan pemeriksaan segera, dengan obat tetes dihentikan sampai dokter hewan menilai.

Penanganan inti: Tangani penyebab dasar dan infeksinya, bukan hanya gejalanya: periksa gendang telinga sebelum obat topikal, ambil sitologi sebelum pembersihan, pilih obat berdasarkan sitologi (antibiotik, antijamur, dan steroid antiinflamasi, topikal maupun sistemik bila perlu), bersihkan telinga dengan lembut, dan lanjutkan sampai sembuh total dengan kontrol ulang; operasi besar hanya bila saluran menutup atau mengapur atau terapi medis gagal.

Pencegahan inti: Tidak ada pencegahan yang menjamin 100% bebas otitis; yang terverifikasi adalah memeriksa telinga rutin, kontrol parasit rutin, mengelola penyakit dasar jangka panjang, tidak membersihkan telinga sehat secara rutin, menjaga telinga tetap kering dan menghindari iritan, mengobati infeksi sampai tuntas, dan memeriksa kucing serumah bila satu kucing terdiagnosis tungau. Tidak ada vaksin khusus otitis eksterna.

Peringatan penting: Jangan pernah memberi obat tetes atau pembersih telinga bila gendang telinga belum dipastikan utuh oleh dokter hewan — aminoglikosida dan polimiksin B dapat merusak telinga dalam secara permanen bila gendang pecah, dan status klorheksidin pada gendang pecah diperdebatkan sehingga jangan ditulis sebagai aman; jangan memakai hidrogen peroksida, cuka, atau cotton bud di dalam saluran, dan jangan memakai obat tetes bebas tanpa diagnosis.

Sumber utama: VCA Animal Hospitals (https://vcahospitals.com/know-your-pet/ear-infections-in-cats); Cornell University College of Veterinary Medicine (https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/otitis); MSD

Veterinary Manual (https://www.msdvetmanual.com/cat-owners/ear-disorders-of-cats/otitis-externa-external-ear-infection-in-cats)